



Nuansa
Fajar
Cemerlang

MUROTAL AL QUR'AN SURAT AL MULK TERAPAN DALAM ASUHAN KEBIDANAN SEBAGAI PENGURANG RASA NYERI PASCA OPERASI SC

Maya Sukmayati
Giari Rahmilasari



Murottal AL Qur'an Surat Al Mulk: Terapan dalam Asuhan Kebidanan Sebagai Pengurang Rasa Nyeri Pasca Operasi SC

**Maya Sukmayati, S.ST., M.KM., Bdn.
Giari Rahmilasari, S.ST., M.Keb., Bdn.**



Murottal AL Qur'an Surat Al Mulk:
Terapan Dalam Asuhan Kebidanan
Sebagai Pengurang Rasa Nyeri Pasca Operasi SC

Penulis: Maya Sukmayati, S.ST., M.K.M., Bdn.
Giari Rahmilasari, S.ST., M.Keb., Bdn.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-29-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Murottal Al Qur'an Surat Al Mulk : terapan dalam asuhan kebidanan sebagai pengurang rasa nyeri pasca operasi SC / Maya Sukmayati, S.S.T., M.K.M., Bdn., Giari Rahmilasari, S.S.T., M.Keb., Bdn.

EDISI

Cetakan pertama

PUBLIKASI

Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

77 halaman ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7139-29-0

SUBJEK

Terapi keagamaan (Islam)

KLASIFIKASI

615.852 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1190318>

Prakata

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas curahan rahmatNya berupa Kesehatan, waktu serta kesempatan sehingga penulis dan tim dapat menyelesaikan penyusunan buku ini tepat waktu.

Buku ini berisi konsep-konsep tilawah dan aplikasi murottal untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien ibu nifas pasca operasi seksio sesaria. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana proses memperdengarkan Murottal Al Qur'an Surat Mulk dapat bermanfaat sebagai pereda rasa sakit.

Sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, umat Islam senantiasa dituntut untuk mengembangkan dan memelihara pola hidup sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al Qur'an maupun hadist dan memberi manfaat bagi Masyarakat sekitar maupun lingkungan. Penggunaan bacaan firman Allah dalam Al Qur'an memberikan rasa tenang dan menjadi salah satu metode relaksasi yang dapat menurunkan tingkat nyeri telah banyak diteliti dan dipraktikan sebagai salah satu jenis asuhan komplementer yang diintegrasikan dalam asuhan kebidanan.

(Desember, 2024)

Penulis

Daftar Isi

Prakata..... iii

Daftar Isi..... iv

Bab 1 Pendahuluan 1

**Bab 2 Al Qur'an, Murottal dan Berbagai Jenis Irama
Pembacaan Al Qur'an Beserta Sejarahnya..... 5**

A. Al Qur'an 5

B. Murottal..... 8

C. Sejarah Nagham..... 9

D. Al Maqamat..... 11

**Bab 3 Murrotal AL Qur'an Surat Al Mulk sebagai
Penurun Rasa Nyeri Pada Ibu Nifas dengan SC 19**

A. Periode Postpartum..... 19

B. Perubahan dan Adaptasi Masa Postpartum 20

1. Sistem Reproduksi..... 21

2. Sistem Urinaria..... 27

3. Sistem Endokrin..... 29

4. Sistem Kardiovaskular 32

5. Payudara..... 33

6. Perubahan Psikologis 35

C. Sectio Cesarea..... 36

1. Definisi Sectio Cesarea..... 36

2. Manajemen Asuhan 37

D. Murrotal Al Quran	39
1. Definisi	39
2. Fungsi Neuroscience dalam Merespon Stress	40
3. Murrotal Al Quran sebagai terapi.....	42
4. Surat Al Mulk	43
5. Aplikasi Terapi Murrotal Al-Quran	44

**Bab 4 Karakteristik, Intensitas Nyeri dan Terapan
Surat Al Mulk Pada Ibu Nifas SC Serta Terapi
Murottal Al Qur'an Sebagai *Pain Relief* Dalam
Asuhan Kebidanan Holistik47**

A. Karakteristik Ibu Post Partum.....	47
B. Intensitas Nyeri pada Ibu Postpartum SC.....	51
C. Terapan Al Qur'an Surat Al Mulk Pada Ibu Nifas dengan SC.....	56
D. Integrasi Spiritual Islam Sebagai Bagian dari Kesehatan Holistik.....	57
E. Murottal Al Qur'an sebagai Pain Relief	61

Bab 5 Penutup64

Glosarium67

Profil Penulis.....68

Bab 1

Pendahuluan

Sectioni Cesarea atau persalinan dengan operasi cesar, dalam sejarahnya, merupakan salah satu prosedur pembedahan tertua. Dokumentasi pertama yang mencatat keberhasilan persalinan dengan jenis ini yaitu pada tahun 1500. Proses persalinan ini membuat sayatan di dinding uterus dan perut saat proses melahirkan untuk mencegah terjadinya bahaya dan kematian ibu dan janin jika dilakukan persalinan pervaginam. Beberapa indikasi medis yang menjadi penyebab diperlukannya persalinan dengan jenis ini adalah KPD (Ketuban pecah Dini), PEB (Pre Eklamsia Berat), panggul sempit, kelainan letak janin (*mal position*), dan gawat janin (*fetal distress*) (Anwar & Safitri, 2022). Akibatnya, sesudah dilakukan sectioni cesarea, umumnya muncul rasa nyeri pada daerah luka bekas sayatan, pengeluaran darah yang banyak saat pembedahan dan tromboflebitis pada tungkai bawah yang dapat terjadi karena efek anestesi spinal (Anwar dkk., 2022).

Prevalensi persalinan dengan sectioni cesarea (SC) meningkat dari tahun ketahun. Selama 10 tahun terakhir, secara global dari hanya 5% menjadi 30-32%, yang beriringan dengan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan dalam jangka pendek maupun panjang pada perawatan ibu, neonatal dan komplikasi masa anak-anak. Bahkan ditemukan mencapai 46,1% di dunia (Antoine & Young, 2021). Indonesia, memiliki prevalensi SC tahun 2023 yaitu mencapai 25,9%, dengan 3

provinsi terbesar yaitu Bali (53,2%), DKI Jakarta (40,8%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (38,1%) (Kemenkes RI, 2023).

Risiko kesakitan dan kematian ibu pada proses persalinan sectio cesarea lebih tinggi yaitu mencapai 8-10 kali lebih tinggi daripada persalinan normal melalui vagina, dan angka kesakitan bayi yang dihasilkan dari proses tersebut memiliki angka yang juga lebih tinggi, bahkan berdasarkan bukti, dapat terjadi perubahan perkembangan kekebalan tubuh, berkurangnya mikrobioma usus, obesitas pada masa kanak-kanak akhir, dan asma, sehingga bayi dengan sectio cesarea lebih mungkin mengalami gejala pernafasan dan memerlukan perawatan NICU (Antoine & Young, 2021).

Nyeri yang dihasilkan dari tindakan tersebut, merupakan respon individu yang dapat dirasakan berbeda-beda tergantung persepsi dari individu tersebut, yang umumnya memunculkan perilaku yang diarahkan untuk menghilangkan atau menghentikan pengalaman tidak menyenangkan yang dirasakannya tersebut (Oliver, 2019; Permata Sari dkk., 2018). Nyeri dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu usia, gender, budaya, lingkungan, ansietas dan stress, pengalaman nyeri masa lalu, dan ambang nyeri. Tubuh memiliki mekanisme untuk merespon nyeri, beberapa diantaranya yaitu bahasa tubuh tegang, muncul gelisah, ekspresi wajah tegang, munculnya air mata, peningkatan resistensi/agitasi dengan gerakan, peningkatan pernafasan, atau bahkan dapat terjadi sesak nafas.

Nyeri, merupakan ketakutan utama yang dikhawatirkan oleh ibu sebelum dan sesudah proses persalinan dengan sectio cesarea (Antoine & Young, 2021). Perubahan fisiologis ibu nifas, ditambah dengan nyeri yang ditimbulkan dari proses sectio cesarea, sehingga dapat menyebabkan ibu mengalami keterbatasan aktifitas fisik terutama terganggunya kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan dirinya (*activity daily living*), akibatnya, respon ibu dan bayi berkurang dan ASI tidak dapat diberikan secara optimal (Yuliana, 2018; Diana, 2019).

Nyeri yang ditimbulkan akibat persalinan dengan sectio cesarea juga dapat menunda mulainya pemberian ASI, dan memendekkan durasi pemberian ASI Eksklusif (Li dkk., 2021). Pemberian ASI pada bayi merupakan cara terbaik untuk memberikan kesejahteraan bayi, seperti direkomendasikan oleh badan kesehatan dunia (*World Health Organization/WHO*), dan *American Academy of Pediatrics (AAP)* bahwa ASI memiliki banyak manfaatnya termasuk untuk perkembangan syaraf bayi, dan pada ibu mampu melindungi dari kanker payudara dan hipertensi (Bollag dkk., 2021).

Maka, dibutuhkan cara untuk mengatasi nyeri. Beberapa teknik untuk mengatasi nyeri yaitu terapi farmakologi, dan non farmakologi. Terapi farmakologi yaitu terapi dengan menggunakan obat-obatan yaitu (1) analgesik perifer (non opioid), yaitu obat golongan anti nyeri yang tidak bersifat adiktif dan dapat dibeli bebas, dan analgesik narkotik (opioid), yaitu golongan anti nyeri yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat memiliki efek samping seperti depresi pernafasan, hipotensi ortostatik, takikardi, mengantuk, konstipasi dan retensi urin. Jenis analgesik opioid memerlukan resep dokter karena memiliki efek yang sangat kuat. Kedua jenis obat-obatan tersebut memiliki efek penurunan rasa nyeri, dari ringan hingga berat. Selanjutnya, adalah terapi non farmakologi, yang prinsipnya adalah mengalihkan perhatian atau membuat pasien lebih rileks sehingga dapat mengatasi nyeri tanpa obat-obatan. Terdapat beberapa teknik non farmakologi yaitu dengan teknik relaksasi nafas dalam, *guided imagery*, dan distraksi. Teknik relaksasi dengan nafas dalam dapat membuat perubahan arus listrik di otot tubuh, sehingga memperbaiki sirkulasi darah dan

kulit. Dampak yang didapatkan setelah melakukan relaksasi nafas dalam ini adalah dapat menurunkan denyut jantung, respirasi dan ketegangan otot. Teknik kedua adalah dengan *guided imagery*, yang mengajak dan membimbing klien untuk berkonsentrasi penuh dengan visualisasi tempat yang indah, menyejukkan dengan situasi yang damai dan tenang seperti dalam imajinasinya masing-masing. Teknik yang ketiga adalah distraksi, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengalihkan fokus perhatian klien pada hal lain yang menarik dan menyenangkan, sehingga dapat menurunkan respon klien terhadap nyeri yang dialaminya, contohnya yaitu melihat video, mendengarkan musik, mendengarkan al-quran (murrotal al-quran), akupunktur, akupressur, biofeedback, meditasi, yoga, manajemen stres, hypnobirthing, dan lain sebagainya (Benzon dkk., 2022; Haniyah dkk., 2023).

Pilihan untuk menggunakan metode yang mana, umumnya berlaku sesuai dengan sosial budaya dan demografis setempat. Indonesia, memiliki data demografi yang memiliki populasi mencapai 269,6 juta jiwa dengan penduduk muslim mencapai 87,2% dari populasi. Hal ini menyebabkan, pendekatan dengan keyakinan penduduk setempat yakni agama Islam, dapat menjadi pilihan. Al Quran sebagai kitab suci umat Islam, menjadi salah satu upaya untuk mendistraksi dengan metode mendengarkan atau murrotal. Murrotal adalah rekaman suara bacaan Al Quran yang dilagukan oleh seorang qori (pembaca ayat quran). Upaya ini dianggap lebih efektif karena akan lebih cepat diterima, karena berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya, yaitu agama Islam (Faridah dkk., 2017). Beberapa penelitian menemukan bahwa murrotal al quran terbukti dapat menurunkan intensitas nyeri pasca sectio cesarea (Haniyah dkk., 2023; Purwati dkk., 2019).

Bab 2

Al Qur'an, Murottal dan Berbagai Jenis Irama Pembacaan Al Qur'an Beserta Sejarahnya

A. Al Qur'an

Berasal dari Bahasa arab, yaitu *q-r-'*; Al Qur'an bermakna hapalan atau bacaan dan merupakan turunan kata pertama dari wahyu yang juga pertama kali diturunkan, iqro (bacalah). Wahyu (*tanzil*), Peringatan (*dzikir*), Pembeda (*furqan*) dan Kitab Suci (*kitab*) adalah nama lain dari Al qur'an untuk menyebut dirinya sendiri. Penyebutan Al qur'an sebagai kitab untuk dirinya sendiri terdapat sebanyak 70 kali, walaupun di jaman Rasulullah SAW masih hidup, Al qur'an belum ditulis dan disusun menjadi sebuah kitab. Penyusunan Al Qur'an menjadi sebuah kitab dilakukan oleh khalifah ke tiga, yaitu Abu Bakar RA.

Struktur Al Qur'an terdiri dari 114 surat dimana dalam setiap surat mengandung beberapa ayat dengan panjang yang bervariasi. Setiap ayat Al Qur'an terdiri dari beberapa kata yang bervariasi, bahkan ada yang hanya satu kata saja. Al Qur'an disusun menurut panjangnya surat, kecuali surat pertama, yaitu Al Fatihah, yang memuat 7 ayat berisi do'a. Surat Al Fatihah wajib dibacakan di setiap raka'at dalam setiap shalat diikuti surat lain sebagai anjuran.

Al Qur'an berisi wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan bahasa arab berisi firman Tuhan yang valid dan nol kesalahan, sebagaimana tertera dalam surat Yunus 37-38, yang berarti : Tidak mungkin al-Qur'an ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi (al-Qur'an) membenarkan Kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya (diturunkan) dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan dia (Muhammad) yang telah membuatnya? Katakanlah, "buatlah sebuah *surah* yang semisal dengan *surah* al-Qur'an, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu (membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar".

Al Qur'an sebagai wahyu merupakan bentuk komunikasi firman Allah yang menyatakan kehendakNya kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril sebagai perantara, dalam bahasa arab. Terdapat beberapa tingkatan wahyu Al Qur'an.



Gambar 2.1
Tingkatan Wahyu Al-Qur'an

Pada tingkat pertama, yaitu Tuhan – lauh Mahfudz – Langit- Jibril, wahyu merupakan tingkatan Yang tidak kasat mata dan tidak difahami manusia. Tingkat kedua adalah merupakan tingkat dimana wahyu dilafadzkan dalam konteks manusia, yaitu, ketika wahyu disampaikan oleh Rasulullah kepada umat yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial dan historis yang beragam. Hal tersebut dimaksudkan agar firman Allah menjadi bagian dari norma, adat dan dan kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu. Melalui al-Qur'an, Allah berkomunikasi baik kepada manusia secara umum maupun kepada masyarakat di sekitar Rasulullah secara khusus. Tingkat ketiga wahyu berkaitan dengan teks yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Artinya, ajaran-ajaran Allah melalui wahyu tersebut sekarang telah dicatat dan dipraktikan serta berkedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Implementasi dan aplikasi wahyu ke dalam kehidupan sosial tersebut dinamakan “aktualisasi”.

Level keempat yang melibatkan dua dimensi wahyu berikutnya masih berlangsung meskipun wahyu sudah ditutup melalui wafatnya Rasulullah SAW. Masyarakat Muslim terus menerus dan semakin mengelaborasi makna-makna dalam wahyu Al Qur'an. Setiap komunitas masyarakat setelah Rasulullah SAW secara berkesinambungan telah berupaya untuk menerapkan makna al-Qur'an ke dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan perspektif al-Qur'an, Allah terus memberikan bimbingan bagi mereka yang percaya dengan keberadaan-Nya dan berupaya untuk mempraktikkan firman-Nya secara benar dan tepat. Meskipun hal tersebut bukanlah merupakan aspek linguistik, tetapi level ini telah ditampilkan melalui interaksi yang berkelanjutan antara bentuk-bentuk linguistik wahyu sebagaimana yang tampak dalam al-Qur'an dan bentuk bentuk linguistik yang dielaborasi sejak generasi Muslim awal (Saeed, 2020).

B. Murottal

Murottal Al-Quran merupakan rekaman dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh seorang pembaca Al-Quran dalam bentuk suara (Fadhli & Mustofa, 2020). Murottal AL Qur'an adalah membaca ayat-ayat suci Al Qur'an dengan perlahan, lambat, tidak tergesa-gesa (tartil) dengan makhraj yang jelas dan benar sesuai tajwid (Ibrahim, 2022). Murottal Al Qur'an tidak perlu menggunakan irama tertentu dan tidak juga memerlukan pernafasan yang tinggi seperti Mujawwad.

Sebagian ulama berpendapat membaca Al Qur'an dengan berirama (nagham) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama memperhatikan persyaratan makhraj dan tajwid yang benar. Pendapat ini didasarkan

kepada suatu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Da'ud Sulayman ibn al-Ash'ath Al-Sijistani, Sahih Sunan Abi Dawud, Vol. 1, No. 1,468, diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib, Riyadh: Maktabat al Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi', 1998, hal. 404, Rasulullah bersabda :“Percantiklah al qur'an dengan suaramu” (Saeed, 2020). Ulama ulama yang memperbolehkan penggunaan naghham diantaranya adalah Abu Hanifah dan para pengikutnya, Imam al-Syafi'i, Abdullah bi Mubarak, Nazr bin Syumail, Abu Ja'far al-Thabari, Abu al-Hasan bin al-Bathal, Abu Bakar bin al-'Arabi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Abi Zakaria Yahya bin Syarifudin al-Nawawi. Sedangkan sebagian lagi berpendapat naghham tidak diperbolehkan. Para ulama yang masuk pada kelompok ini antara lain Imam Ahmad bin Hambal dan Malik bin Anas (Nurhidayati dkk., 2020)

Walaupun Al Qur'an secara eksternal maupun internal mengandung unsur seni, ayat-ayat suci Al Qur'an bukanlah puisi, melainkan pelajaran dan kitab yang jelas, sehingga memahami makna dari ayat-ayat suci Al Qur'an tetap harus diutamakan. Bantahan penegasan ini terdapat dalam Q.S Yasin: 69-70, yang berarti : “Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas, agar dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir”(AL Qur'an, 2024).

C. Sejarah Nagham

Arab

Terdapat berbagai teori terkait naghham yang dikemukakan oleh Ibnu Manzur, yang dikutip oleh Basyar

Awad Ma'ruf dalam *Al-Bayan fi Hukm al-Taghanni bi al-Quran*. Pertama, *nagham Al Qur'an* berasal dari nyanyian nenek moyang bangsa arab. Adapun teori kedua menyebutkan *nagham al qur'an* berasal dari nyanyian tawanan perang budak-budak kafir yang pada perkembangannya, kedua teori tersebut menyatakan setelah Islam datang, syair lagu-lagu yang mereka nyanyikan diganti dengan ayat-ayat Al Qur'an (Nurhidayati dkk., 2020).

Ibnu qutaibah menjelaskan bahwa pasca wafatnya rasulullah saw, gubernur Sijistan, 'Ubaidillah ibn Abi Bakrah, yang menjabat tahun 697 M adalah merupakan orang pertama yang membaca Al Qur'an menggunakan irama musik arab dalam nada menyentuh dan penuh kelembutan. Kemampuan 'Ubaidillah dalam membaca Al Qur'an dengan irama indah tersebut dilanjutkan oleh cucunya, yaitu 'Ubaidillah ibn 'Umar dengan bacaan yang lebih berkarakter, sehingga dikenal dengan nama qiraat ibnu umar.

Ibnu umar menurunkan ilmu qira'atnya kepada al-'Ibadhi yang selanjutnya mewariskan kepada Sa'id al-'Allaf dan saudara lelakinya. Khalifah Harun al-Rasyid (763 M-809) kemudian melantik Sa'id al-'Allaf menjadi qari' istana. Selanjutnya muncul nama-nama al-Haitsam, Aban dan Ibn A'yun. Masrurin dalam kajiannya menemukan bahwa rekaman al-Qur'an paling tua pertama kali ditemukan Cristian Snouck Hurgronje pada tahun 1855 di kota Mekah (Nurhidayati dkk., 2020).

Indonesia

Penelitian Anna M. Gade menyebutkan bahwa *nagham* masuk ke Indonesia sebelum tahun 1960 melalui para ulama, muslim yang beribadah haji dan pelajar yang pergi ke tanah suci Makah. Perkembangan *nagham* di Indonesia marak di

awal tahun 2000 dengan gaya mujawwad. Mereka membawa lagu yang dikenal dengan gaya makkawi yang dikelompokkan dengan nama banjakah, hirab, maya, rakby, jiharka, sika, dan dukkah, yang disingkat dengan bihamrin jasadin, bermakna jasad yang kemerah-merahan.

Para Qari membawakan lagu tersebut dengan lengkap dari tangga nada rendah hingga tinggi (jawab al jawab). Lagu-lagu di atas digunakan dalam bentuk murattal untuk hapalan al-Qur'an. K.H. Arwani (Kudus), K.H. Sya'rani (Kudus), K.H. Munawwir (Krapyak-Yogyakarta), K.H. Abdul Qadir (Krapyak-Yogyakarta), K.H. Damanhuri (Malang-Jawa Timur), K.H. Ma'mun (Serang-Banten), K.H. Muntaha (Wonosobo), K.H. Azra'i Abdul Ra'uf (Medan) merupakan qari-qari yang menggunakan gaya lagu-lagu tersebut.

Selanjutnya lagu misriy mulai masuk ke Indonesia dan dalam perkembangannya mendominasi di Indonesia. Selain gaya lagu, para qari juga mulai bertambah dengan membawa lagu makkawi dalam bentuk mujawwad. Bertambah banyaknya jumlah qari dengan perkembangan yang pesat membuat beberapa ulama yang terafiliasi dengan organisasi Nadhlatul Ulama (NU) mendirikan sebuah perkumpulan qari-qari di Indonesia tahun 1950 yang diberinama *Jam'iiyyatu al-Qurra' wa al-H{uffaz* (persatuan para qari dan *hafiz* /JQH).

D. Al Maqamat

Maqaamaat (modus melodi) adalah jenis nada atau melodi yang digunakan oleh musisi dan penyanyi. Maqam adalah nama suatu jenis nada dalam musik Persia-Arab dan Timur Tengah. Setiap maqamat mempunyai sistem hubungan jenis, kecenderungan dan keterkaitan yang

berbeda antara derajat kodenya. Masing-masing dari derajat-derajat maqamat dibangun dalam urutan tertentu terhadap maqamat yang lain, melalui hubungan interval yang tetap.

Sebuah model tangga nada terdiri dari satu oktaf yang terdiri dari kombinasi dua atau tiga rangkaian berikut: trichord, tetrachords atau pentachords, (dalam bahasa Arab: Tabe', Jins atau Ajnas dalam bentuk jamak, dan Eqed). Demikian, setiap mode mempunyai satu barisan primer, dan satu atau lebih barisan sekunder. Tiga metode membuat modal skala gabungan tetrakordal (Jam'e) dalam sistem modal adalah:

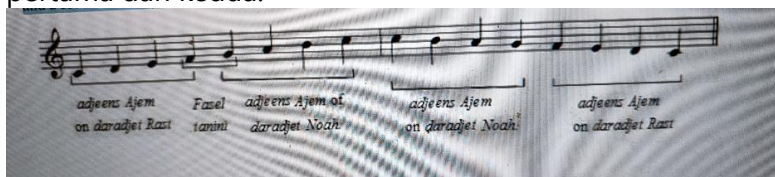
- Terpisah (Munfasil).
- Konjungsi (Muttasil).
- Tumpang tindih (Mutadkhil).

Mereka yang berspesialisasi dalam seni itu telah mengklasifikasikan lagu-lagu berdasarkan ritme tertentu dan menyebutnya maqaamaat (Hakiman dkk., 2021). Ini bukanlah ilmu yang ditemukan, melainkan disusun dengan mempelajari dan mendengarkan lagu-lagu orang, seperti yang dilakukan oleh al-Khaleel ibn Ahmad al-Faraheedi dengan irama puisi. Adapun mode-mode melody maqamat yang dikenal secara umum adalah sebagai berikut:

Maqaam al-Ajam

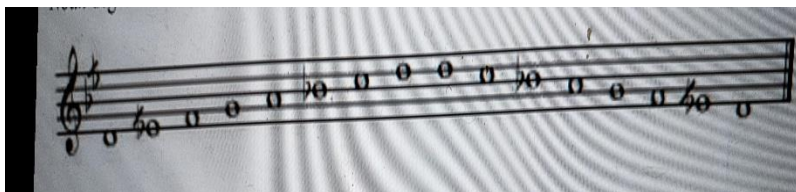
Maqamat ini memiliki kekuatan batin, kejernihan dan perasaan bahagia. Karena kecantikannya, jiwa memperjuangkan kemerduannya, ditandai dengan adanya ketelitian dan kelancaran dalam pengembangannya sehingga menghasilkan emosi yang kuat. Maqamat Ini digunakan pada penampilan himne dan lagu militer, serta pada ketika ada perbincangan tentang penentuan nasib jiwa

atau apakah akan diarahkan ke surga atau ke neraka. Terdiri dari Jins Ajem di daradjet Rast dan Jinss Ajem kedua dari daradjet Noah. Fasel tanini berada di antara tetrachord pertama dan kedua.



Maqaam al-Bayyat (Bayati)

Ini adalah maqamat yang membangkitkan kerendahan hati dan monastisisme. Maqamat yang memusatkan hati dan membuatny merenungkan ayat-ayat Allah dan artinya.

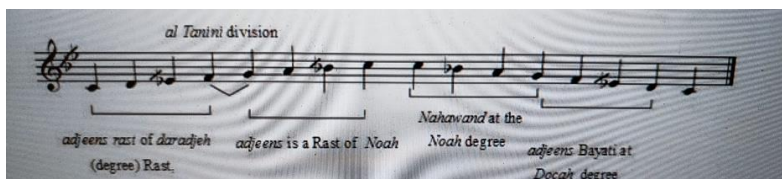


Maqaam ar-Rast (Rast)

Rast berakar dari kata Persia yang berarti ketabahan. Spesialis di maqaamaat lebih suka maqaam ini ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan narasi atau menentukan aturan. Maqamat ini memiliki keterusterangan dan keindahan yang sederhana. Rast memiliki karakter maskulin yang kuat dan damai. Digunakan ketika ayat yang dibacakan bersifat merdu dan puitis.

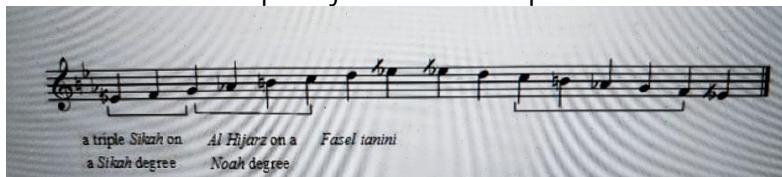
Sebagian besar imam dari Madina Munawarah dan Haram Sharif (Mekah) seperti Alhadifi, Sdais dan Al Mushsinio, membaca Al-Qur'an dengan Maqamat Rast. Selama tajwid sebagian besar pembaca memulainya dengan Rast atau Bayati, karena keduanya ini diakui termasuk memiliki skala

yang paling indah. Rast terdiri dari dua tetrachord, yang pertama adalah Jins Rast dari daradjeh (derajat) Rast, sedangkan Jin kedua adalah derajat Rast Nuh.



Maqam al Hazan

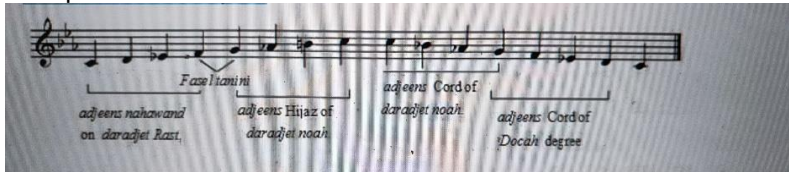
Maqam ini lambat dan merenggang serta masuk ke lubuk hati yang terdalam, membantu para pembaca dan pendengarnya untuk mencapai hikmah Al-Qur'an. Melodinya bersifat lembut dan ekspresif, memberikan emosi dan kelembutan yang indah, digunakan dalam ayat-ayat yang bercerita tentang surga. Maqamat ini terdiri dari dua Jin. Yang pertama adalah sikah rangkap tiga pada a Derajat Sikah, sedangkan yang kedua adalah Al Hijarz pada derajat Nuh. Fasel tanini muncul pada jin akhir babak pertama dan kedua.



Maqam an-Nahaawand (Nahawand)

Maqam ini membangkitkan emosi kasih sayang dan kelembutan, dan menanamkan kerendahan hati dan refleksi. Nahawand diambil dari nama salah satu kota di Iran. Qari-qari yang terkenal dalam maqamat ini adalah Al Fassi dan Shatri. Maqamat ini paling banyak digunakan dalam ekspresi cerita dalam al qur'an. Maqam Al Nahawand mempunyai dua Jin: yang pertama adalah nahawand pada daradjet Rast, yang

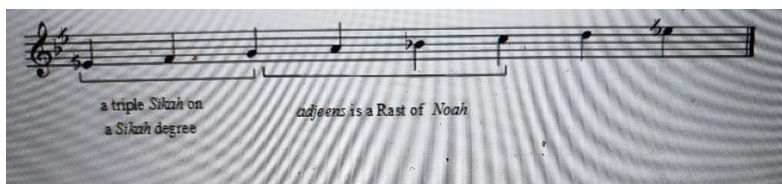
kedua adalah Kartu daradjet Nuh. Fasel tanini mengikuti setiap Jin



Maqaam as-Seeka (Sikah)

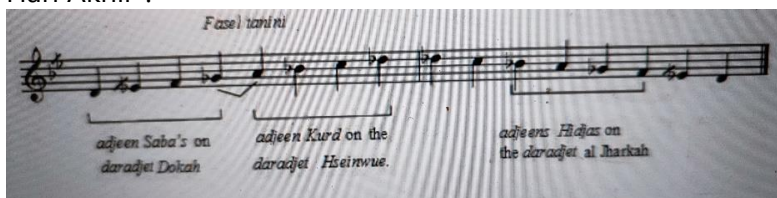
Nama Sikah berasal dari bahasa Persia dan terdiri dari dua kata, yaitu si yang berarti tiga, dan ka yang berarti tali. Maqamat jenis ini menampilkan peregangan dan kesedihan, serta pengampunan. Kemerduannya membantu masuk ke dalam ayat yang didedikasikan untuk kebesaran Tuhan. Hal ini juga digunakan dalam pembacaan dongeng dan legenda dalam Al-Qur'an. Ada banyak lagu pemujaan berdasarkan maqam Sikah.

Salah satunya telah sampai kepada kita, "Talla al Budr alena" atau "Bulan Purnama Telah Menunjukkan Dirinya Kepada Kita". Dengan lagu ini, Nabi Muhammad SAW disambut oleh orang-orang di Madinah Monawarah. Lagu ini sering dikutip oleh para penganut musik sebagai bukti fakta bahwa Nabi (saw) menyukai musik dan karenanya dengan gembira menyambut lagu ini dari orang-orang yang menyambutnya. Maqamat ini terdiri dari triple Sikah trichord yang disebut Tabe' Sikah, sedangkan tetrachord kedua adalah Rast pada darajet Noah. Salah tanini lagi-lagi berada di akhir setiap Jin. Maqaamat ini dibedakan dengan langkahnya yang lambat dan mudah.



Maqaam as-Saba (Saba)

Maqaam ini sangat spiritual dan kuat, dan membangkitkan emosi kasih sayang. Ini digunakan di beberapa tempat. Maqamat ini focus menggambarkan tentang nikmat ilahi dalam teks Al-Qur'an. Melaluinya, pembaca dapat menyampaikan emosi yang mengejutkan, ayat yang dibacakan dengan maqamat ini mengacu pada Kiamat dan Hari Akhir".

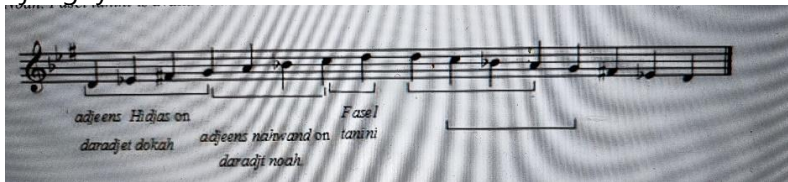


Maqam Saba terdiri dari Jins Saba di daradjet Dokah dan Jins Kurdi kedua di daradjet Hseinwue. Fasel tanini berada di antara tetrachord pertama dan kedua.

Maqaam al-Hijaaz (Hijaz)

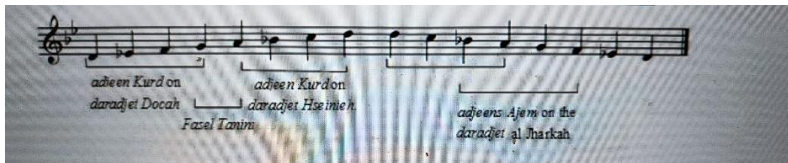
Ini adalah maqaam asal Arab, dinamai menurut wilayah Hijaz di Arab. Ini adalah salah satu maqaam paling spiritual dan salah satu yang paling efektif dalam membantu seseorang untuk fokus dalam membaca bacaan ayat dalam Al-Qur'an. Berkarakter halus, lembut, tenang serta membawa kesedihan. maqamatnini digunakan dalam ayat yang menceritakan tentang kebahagiaan surga. Maqamat Al Hidjaz terdiri dari Jin Hidja pertama pada daradjet Dokah dan Jin Nahwand

kedua pada daradjt Nuh. Fasel tanini tersedia di tiap ujungnya.



Kurdi

Ini adalah jenis maqamat yang populer, berkarakter emosional dan lembut, tetapi juga dapat digunakan pada topik yang berhubungan dengan kebaikan, keindahan dan kehalusan alam. Maqamat Kurdi terdiri dari Jins Kurdi pertama di daradjet Docah dan Jins Kurdi kedua di daradjet Hseinieh. Fasel Tanini berada di antara tetrachord pertama dan kedua. (Bakri, 2016)



Bab 3

Murrotal AL Qur'an Surat Al Mulk sebagai Penurun Rasa Nyeri Pada Ibu Nifas dengan SC

A. Periode Postpartum

Masa nifas atau dikenal juga dengan puerperium atau periode postpartum adalah masa yang dimulai setelah kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Periode nifas dimulai sejak dua jam setelah lahir placenta, dan umumnya berakhir setelah 6 minggu. Asal kata puerperium yaitu dari bahasa latin, yaitu "*puer*" yang artinya bayi dan "*parous*" melahirkan (Panda dkk., 2021). Secara umum, 40-45% kematian ibu terjadi antara awal persalinan dan periode 24 jam setelah melahirkan, terutama di negara dengan penghasilan rendah dan menengah (Dol dkk., 2022).

Sehingga pelayanan pascapersalinan yang berkualitas harus terselenggara dan sama pentingnya dengan pelayanan kehamilan untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi (Lambermon dkk., 2020).

Periode ini merupakan masa transisi yang membuat tekanan/stress, hal ini karena perempuan akan menghadapi perubahan fisik dan emosi yang menantang dalam peran barunya sebagai ibu. Perubahan ini biasanya dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan akan dukungan sosial dan kebutuhan ekonomi (Bashour dkk., 2008).

Perubahan fisik yang terjadi meliputi keseluruhan dari sistem dalam tubuh perempuan yang berdasarkan pada *National Institute for Health and Care Excellence Guidelines*, periode ini dapat dibagi menjadi tiga periode utama, yaitu (Sharma, 2016):

1. *Initial phase* yaitu selama 24 jam persalinan, atau dikenal juga dengan istilah *immediate postpartum*.
2. *The second phase*, yaitu sejak hari ke-2 sampai hari ke-7, atau dikenal juga dengan istilah *early postpartum*
3. *The final phase*, yaitu dari hari ke-8 sampai hari ke 42 atau dikenal juga dengan istilah *late postpartum*

Lyon, membagi periode ini menjadi "*acute phase*", yang berlangsung selama 6-12 jam postpartum, "*subacute phase*" yang berlangsung selama 2-6 minggu, dan "*delayed phase*" yang dapat berlangsung hingga 6 bulan (Sharma, 2016).

B. Perubahan dan Adaptasi Masa Postpartum

Perubahan utama yang terjadi pada periode ini adalah pada sistem reproduksi, payudara, saluran kemih, sistem kardiovaskuler, dan lain sebagainya. Berikut akan di bahas dari masing-masing sistem organ.

1. Sistem Reproduksi

Perubahan Uterus

Pada saat persalinan, berat uterus adalah sekitar 1 kg, tanpa plasenta, air ketuban, dan lainnya. Sesudah 6 minggu, beratnya menjadi sekitar 500-100gr. Dua minggu pertama persalinan, terjadi penurunan ukuran sel-sel miometrium akibatnya pengurangan ukuran dan berat yang paling maksimal, selanjutnya penurunannya akan bertahap. Proses pengembalian bentuk dan ukuran uterus pada keadaan sebelumnya ini disebut sebagai proses involusi uterus. Pada akhir minggu ke-6, uterus akan menyusut ke bentuk sebelum hamil, namun secara umum, besar uterus akan lebih besar dari pada saat sebelum hamil.

Afterpains

Sesudah persalinan, akan muncul rasa nyeri akibat kontraksi. Umumnya pada ibu multipara, uterus berkontraksi dengan irama intermitten (hilang-timbul), yang umumnya muncul pada saat menyusui. Hal ini karena hisapan bayi menyebabkan pelepasan oksitosin yang merangsang kontraksi. Umumnya rasa nyeri ini bisa di adaptasi dengan baik, dan intensitasnya berkurang pada hari ke-3. Namun beberapa ibu mungkin membutuhkan analgesik untuk mengatasi nyeri yang dirasakan.

Kadar esterogen dan progesteron yang sangat rendah di masa nifas, dapat membuat ukuran uterus agak lebih kecil dibanding yang normal. Berdasarkan temuan, 80% ibu yang menyusui, memiliki uterus yang lebih kecil pada bulan ke-3, jika dibandingkan ibu yang tidak menyusui.

Tinggi Uterus

Segera setelah persalinan, uterus berada 2cm dibawah pusat (umbilicus). Dalam 12 jam fundus mungkin naik sekitar 1cm diatas pusat, dan dalam 24 jam ukurannya menyerupai uterus pada kehamilan 20 minggu, pada hari ke-6 postpartum, uterus sudah berada di pertengahan pusat dan symphysis pubis. Setelahnya, berkurang sekitar 1 ruas jari setiap 24 jam, dan setelah hari ke-10 postpartum, uterus sudah tidak teraba di abdomen.

Endometrium

Endometrium merupakan lapisan tipis dan halus yang membentuk bagian dalam dinding rahim. Lapisan ini terdiri dari sel-sel epitel dan jaringan ikat yang sangat kaya dengan pembuluh darah (vaskuler). Glandula endometrial adalah kelenjar kelenjar kecil yang terdapat dalam lapisan endometrium.

Pada masa nifas, dalam 2-3 hari, sisa-sisa desidua terbagi menjadi dua lapisan, yaitu:

- a. *Superficial Layer*. Pada lapisan ini terjadi nekrosis, dan kemudian menyebabkan lapisan ini terlepas. Lapisan ini keluar melalui vagina selama tiga minggu pertama postpartum. Lapisan ini yang biasa kita kenal dengan lokia.
- b. *Basal Layer* (berbatasan dengan miometrium) merupakan residu dari kelenjar endometrial. Lapisan ini akan berubah menjadi endometrium yang baru. Pada hari ke-7 kelenjar endometrium mulai tampak, dan regenerasi dari endometrium, akan membaik pada waktu 16 hari postpartum, kecuali pada tempat melekatnya plasenta.

Tempat Plasenta

Sesudah lahirnya plasenta, terdapat otot polos yang berkontraksi dan menekan pembuluh darah di tempat menempelnya plasenta, yang pada masa ini mengecil dan berbentuk tidak beraturan. Endometrium tumbuh dan menutupi daerah lepasnya plasenta, sehingga endometrium dapat melanjutkan perubahan siklusnya dan memungkinkan terjadinya implantasi dan plasentasi pada kehamilan berikutnya.

Lokia

Keluarnya sisa desidua setelah persalinan disebut lokia. Rahim memiliki kemampuan unik untuk bisa membersihkan dirinya sendiri dari sisa-sisa proses persalinan, yang terdiri dari darah, jaringan, dan lendir yang masih bisa ada sampai 6 minggu postpartum, atau beberapa wanita bisa lebih lama. Berdasarkan warna dan sifat daranya, lokia dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Lokia rubra, berwarna merah, yang agak kental berisi darah segar, muncul pada hari ke 2-4.
- b. Lokia serosa, berwarna merah muda ke coklatan, cairan ini muncul hingga hari ke-10
- c. Lokia alba, berwarna putih kekuningan yang tipis dan umumnya sampai lebih dari minggu ke-5.

Pada beberapa perempuan yang mendapatkan oksitosin, umumnya lokia menjadi lebih sedikit. Pada perempuan dengan sectio cesarea, lokia bisa berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan persalinan melalui vagina. Kadang terasa agak banyak keluar lokia sesudah menyusui, hal ini karena proses menyusui melepaskan oksitosin. Lokia memiliki bau khas darah menstruasi,

dan lokia yang berbau busuk, mengindikasikan terjadinya infeksi, umumnya endometritis.

Serviks

Serviks awalnya lunak dan ada sedikit bengkak, dan pada minggu pertama kembali menjadi kencang dan tebal. Selama persalinan serviks telah berdilatasi hingga 10cm, setelah persalinan ia kembali mengecil, sampai tinggal kira-kira 2 jari pada hari ke-6 postpartum. Pada akhir minggu ke-2, serviks hampir menutup sama sekali, namun bentuknya menjadi bercelah melintang (seperti mulut ikan) bukan melingkar seperti yang dilihat pada perempuan nullipara (belum pernah melahirkan).

Vagina

Setelah persalinan melalui vagina, vagina menjadi agak bengkak dan lembek. Perbaikan vaskularisasi dan bengkak dimulai pada minggu ketiga dan ruggae mulai muncul jika tidak menyusui. Ruggae vagina akan benar-benar kembali pada 6-10 minggu. Pada ibu menyusui, kembalinya ruggae akan sedikit terlambat, hal ini karena tingkat estrogen yang terus berkurang.

Perineum dan Otot Panggul

Pada persalinan pervagina, bengkak dan memar yang terjadi, sembuh dalam 1-2 minggu. Tonus otot kembali menguat dalam 6 minggu dan terus meningkat dalam beberapa bulan. Kekuatan otot perineum akan kembali sesuai dengan tingkat keparahan cedera yang terjadi selama persalinan. Penjahitan luka robekan spontan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan

dengan penjahitan luka episiotomi (Sagi-Dain dkk., 2021). Berdasarkan observasi menggunakan USG rotasi 3 dimensi, baik yang mengalami luka robekan perineum derajat 1 atau 2, dengan yang dilakukan episiotomi, menunjukkan *pelvic morphometry* abnormal pada penelitian menggunakan USG 3 dimensi rotasi sesudah 3 bulan postpartum. Namun implikasi jangka panjang harus dievaluasi ulang, karena pencitraan panggul yang abnormal, tidak secara langsung menyebabkan gejala klinis yang signifikan (Leombroni dkk., 2021).

Senam Kegel (*Kegel Excercise*), sangat direkomendasikan dilakukan sesudah persalinan, karena dapat membantu penguatan otot perineum dan mempercepat penyembuhan. Senam ini melakukan secara reguler kontraksi dan relaksasi pada otot yang menyangga kandung kemih dan uretra. Penguatan pada otot ini dapat mencegah atau mengurangi kehilangan urin yang tidak disadari. Bahkan senam kegel dan terapi fisik juga disarankan bagi perempuan yang melahirkan dengan sectio cesarea (Kuravska dkk., 2022)

Dinding Abdomen

Sesudah persalinan, dinding abdomen menjadi lunak dan relatif longgar untuk beberapa minggu. Pemulihan dibantu oleh latihan. Pada perempuan yang tidak berolahraga, akan memiliki otot abdominal yang lunak dan longgar.

Perbedaan nyata antara persalinan sectio cesar dan persalinan melalui vagina, selain pada otot perineum, tentu saja pada dinding abdomen, tempat persalinan melalui sectio dilakukan. Perempuan yang menjalani sectio cesarea menunjukkan perubahan

signifikan pada fasia abdomen dan ketebalan otot, sedangkan wanita yang menjalani persalinan melalui vagina menunjukkan perubahan pada otot utama. Pada perempuan dengan sectio cesarea, akan terjadi otot *Rectus Abdominis* yang lebih tipis dan atau *Internal Oblique* yang tidak simetris, *Inter Rectus Distance* (*diastasis recti*) yang lebih lebar, jaringan ikat (*Loose Connective Tissue*) dan otot perimuscular abdomen yang lebih tipis, sehingga dapat menyebabkan defisit otot dan perubahan pergerakan fasia, sebagai pemicu terjadinya nyeri jaringan parut, nyeri abdomen, nyeri punggung bawah dan atau nyeri panggul (Fan dkk., 2020).

Rectus Abdominis dan *Internal Oblique* sangat dipengaruhi oleh kehamilan dan persalinan. Selama kehamilan, abdomen membesar, maka otot, fascia, sub kutan, dan seluruh jaringan di abdomen mendapatkan tekanan seiring dengan meningkatnya volume abdominal. Jaringan abdomen menjadi lebih tipis sampai persalinan. Pada

Sel Telur

Kembali normalnya fungsi sel telur tergantung pada proses menyusui. Jika perempuan tidak menyusui, maka ovulasi dapat terjadi paling cepat setelah 27 hari. Rerata terjadi pertama kali menstruasi kembali yaitu 55-60 hari, dan pada banyak perempuan, biasanya terjadi pada minggu ke 12. Namun jika proses menyusui terjadi, akan ada keterlambatan proses menstruasi. Hal ini karena ovulasi di tekan dengan tingginya prolaktin yang muncul selama menyusui. Hormon GnRH (Gonadotropin releasing Hormone) dipengaruhi oleh prolaktin.

Kebanyakan perempuan yang menyusui, mulai menstruasi kembali pada 36 minggu sesudah persalinan (Sharma, 2016).

Fungsi Seksual

Hubungan seksual dapat dilakukan setelah lokea berhenti, vulva dan vagina telah sembuh, dan perempuan telah siap secara fisik dan emosi. Kesiapan fisik biasanya membutuhkan waktu 3-5 minggu, namun pada beberapa perempuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama merasa siap, dan dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Perempuan dengan trauma mayor memiliki ketakutan untuk memulai hubungan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan dengan trauma persalinan minor.

2. Sistem Urinaria

Fungsi Ginjal

Perubahan anatomi ginjal, seperti ureter yang berdilatasi, bertahan sekitar 5 hari postpartum, dan adanya hipotonia yang diakibatkan kehamilan, dibutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk mengembalikan ke keadaan sebelum hamil. Pada sebagian kecil perempuan, keadaan ureter yang tetap berdilatasi seperti saat kehamilan dapat terjadi hingga 3 bulan atau lebih, dan hal ini dapat memicu terjadinya infeksi saluran kemih (Isley & Katz, 2017). Fungsi ginjal kembali normal dalam 8 minggu sesudah persalinan (Lowdermilk dkk., 2019).

Glycosuria yang terjadi akibat kehamilan menghilang setelah 1 minggu sesudah persalinan. Pada perempuan yang menyusui dapat terjadi *lactosuria*.

Kadar nitrogen urea darah meningkat selama masa nifas karena adanya autolisis pada keadaan involusi uterus. Kadar plasma kreatinin kembali normal dalam 6 minggu postpartum. Kehamilan yang berhubungan dengan keadaan proteinuria teratasi dalam 6 minggu setelah persalinan (Blackburn, 2017). Ketonuria dapat terjadi pada perempuan tanpa komplikasi persalinan atau pada keadaan perpanjangan persalinan (*prolonged labour*) dengan dehidrasi (Lowdermilk dkk., 2019).

Hilangnya Cairan

Dalam 12 jam setelah persalinan, mulai terjadi berkurangnya kelebihan cairan di jaringan yang terakumulasi selama kehamilan. Diuresis postpartum terjadi karena penurunan kadang esterogen, hilangnya tekanan vena pada ekstermitas bawah, proses persalinan yang menyebabkan peningkatan volume darah sehingga membantu tubuh untuk membuat kelebihan cairannya. Pengeluaran urine umumnya mencapai 3000ml atau lebih per hari selama 2-3 hari pertama setelah persalinan adalah normal. Hilangnya cairan melalui keringat dan meningkatnya pengeluaran urine bisa membuat penurunan berat badan sekitar 2-3kg selama masa nifas awal (Cunningham dkk., 2019)

Urethra dan Kandung Kemih

Persalinan, dapat memicu terjadinya trauma, peningkatan kapasitas kantung kemih sesudah persalinan, dan efek dari paparan anastesia (epidural ataupun spinal) dapat menyebabkan terjadinya penurunan keinginan untuk berkemih. Selain itu nyeri panggul juga dapat terjadi akibat persalinan, laserasi

pada vagina maupun perineum, atau episiotomi dapat menurunkan atau mengubah refleks keinginan berkemih. Penurunan keinginan berkemih, dan adanya diuresis postpartum, dapat menyebabkan distensi kandung kemih.

Segera setelah persalinan, perdarahan yang banyak dapat menyebabkan kantung kemih menjadi distensi, hal ini menyebabkan uterus terdorong keatas dan menghambat terjadinya kontraksi pada uterus. Nantinya, pada asa nifas terjadinya overdistensi pada kandung kemih, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi dan menghalangi kembali normalnya keinginan berkemih. Dengan pengosongan kandung kemih yang adekuat, tonus otot pada kandung kemih umumnya kembali pada 5-7 hari sesudah persalinan.

Pada beberapa perempuan terjadi *stress incontinence* selama periode postpartum, dan umumnya terjadi pada persalinan melalui vagina, daripada persalinan caesar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya trauma pada jaringan di dasar panggul akibat usaha meneran pada saat persalinan atau pada persalinan dengan bayi besar.

3. Sistem Endokrin

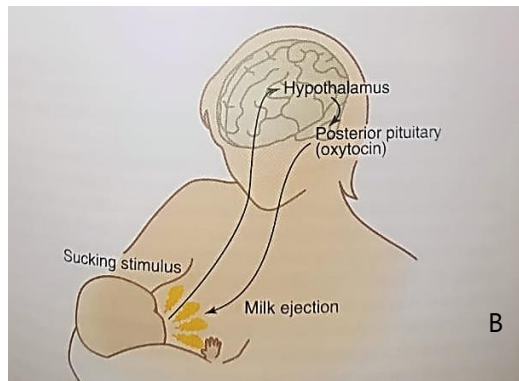
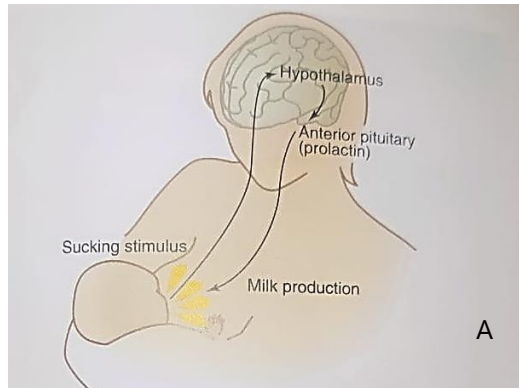
Hormon Placenta

Perubahan hormon yang signifikan terjadi selama masa nifas. Keluarnya placenta menghasilkan penurunan hormon yang dihasilkan oleh placenta secara dramatis. Kadar esterogen dan progesteron turun drastis sesudah persalinan dan mencapai nilai terendahnya pada 1 minggu setelah persalinan. Penurunan kadar esterogen ini berhubungan dengan diuresis.

Hormon Pituitary

Sesudah persalinan, menurunnya kadar progesteron secara drastis, memicu peningkatan hormon prolaktin. Prolaktin di produksi oleh pituitary anterior, yang menstimulasi produksi ASI. Pada perempuan yang menyusui, kadar prolaktin tertinggi adalah pada bulan pertama sesudah persalinan dan tetap meningkat selama masih menyusui. Kadar serum prolaktin dipengaruhi oleh frekuensi menyusui, durasi dari setiap menyusui, dan penggunaan suplemen menyusui. Perbedaan kekuatan hisapan dari masing-masing bayi juga memengaruhi kadar prolaktin. Pada perempuan yang tidak menyusui, kadar prolaktin menurun sesudah persalinan dan mencapai kadar prolaktin seperti sebelum hamil pada 3 minggu postpartum (Isley & Katz, 2017).

Pituitary posterior memproduksi oksitosin sebagai respon dari menyusui atau stimulasi pada putting susu dengan pengeluaran ASI. Oksitosin merangsang pengeluaran ASI atau let-down refleks yang melepaskan susu ke putting susu dari tempatnya di produksi yaitu alveoli di payudara. Seperti dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 (A) Produksi susu (hormon prolaktin, dihasilkan oleh pituitary anterior), (B) Pengeluaran (Ejeksi) susu (hormon oksitosin, dihasilkan oleh pituitary posterior)

Perubahan Metabolisme

Penurunan hormon dari placenta seperti laktogen, esterogen, kortisol, dan enzim plasenta menghasilkan efek terbalik dari diabetogenik, yang mengakibatkan kadar glukosa darah jauh lebih rendah pada periode segera setelah melahirkan. Ibu dengan diabetes tipe 1 akan memiliki insulin yang lebih rendah

pada beberapa hari setelah melahirkan, terutama jika mereka menyusui. Hal ini karena perubahan hormonal yang normal terjadi membuat periode transisi untuk metabolisme karbohidrat, pada periode ini cukup sulit untuk menentukan hasil dari tes toleransi gula pada ibu. Kelenjar thyroid secara bertahap kembali normal dalam 3 bulan setelah persalinan. Kadar thyroxine dan triiodothyronine menurun pada kadar sebelum hamil dalam 4 minggu. Terdapat peningkatan risiko terjadinya *thyroiditis* autoimun sementara pada periode postpartum (Isley & Katz, 2017).

Kadar metabolisme basal tetap tinggi pada 1-2 minggu pertama sesudah melahirkan, yang akan kembali pada kadar sebelum hamil.

Perubahan Suasana Hati

Menurunnya kadar estrogen dan progesteron secara drastis, dianggap sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam perubahan suasana hati yang terjadi pada masa nifas. Perubahan aktifitas, pola tidur dan stress juga berkontribusi pada perubahan suasana hati (Sharma, 2016).

4. Sistem Kardiovaskular

Perubahan hemodinamik yang terjadi pada masa nifas, dapat dirangkum seperti dibawah ini:

- a) Volume darah menurun, pada persalinan melalui vagina menurun sekitar 10%, dan pada persalinan sectio cesarea 5-30%.
- b) Cardiac Output meningkat sebanyak 60-80% segera setelah persalinan. Hal ini karena terjadinya

pertukaran volume karena perlekatan plasenta yang terlepas menyebabkan peningkatan volume pada pembuluh darah balik vena. Peningkatan volume darah ini bertanggungjawab atas terjadinya diuresis pada masa awal nifas dan penurunan jumlah hematokrit. Jumlah ini turun terus hingga sedikit lebih tinggi pada keadaan sebelum hamil, dan menetap pada keadaan tersebut selama beberapa minggu postpartum.

- c) Peningkatan volume stroke
 - d) Denyut jantung menurun, penurunannya kurang lebih 4-17 denyut per menit.
 - e) Tekanan darah bervariasi tergantung kehilangan darah yang terjadi dan parameter hemodinamik lainnya. Resistensi pembuluh darah kapiler umumnya meningkat atau tetap.
- Kebanyakan dari parameter jantung akan kembali pulih dalam 2 minggu pertama sesudah persalinan, dengan perubahan bertahap sampai 4-5 bulan kedepan (Sharma, 2016).

5. Payudara

Laktasi

Tiga tahapan laktogenesis muncul pada saat masa nifas. Tahap pertama muncul pada saat kehamilan. Laktasi ada dengan bantuan dua hormon yaitu prolaktin dan oksitosin.

Prolaktin merangsang kelenjar susu (*mammary glandular ductal growth*) dan menginduksi sintesis protein susu. Oksitosin berhubungan dengan pengeluaran susu atau *let down refleks*. Hisapan bayi, menciptakan impuls aferen yang merangsang kelenjar

pituitary posterior. Oksitosin menyebabkan kontraksi dari sel-sel mioepitel yang tersambung dengan saluran payudara dan membantu pengeluaran susu. Sintesis susu tetap berlangsung konstan sekitar 800ml per hari. Produksi ASI tergantung pada kesehatan ibu. Karenanya, stress dan kelelahan akan berdampak buruk pada persediaan susu oleh dopamin, norepineprin, atau keduanya, yang menghambat sintesis prolaktin. Istirahat adalah kunci sukses dari menyusui.

Air Susu Ibu memiliki banyak nutrisi sebagai sumber makanan yang ideal untuk pertumbuhan bayi. Terdapat cairan bioaktif yang dapat mengembangkan dari kolostrum menjadi ASI matur.

Ibu yang menyusui

Selama 24 jam setelah persalinan, terdapat perubahan kecil pada jaringan payudara. Kolostrum atau susu awal, sebuah cairan kekuningan, dapat keluar dari payudara. Secara bertahap payudara akan menjadi penuh dan berat seiring dengan transisi dari kolostrum ke ASI matur pada 72-96 jam sesudah persalinan; hal ini seringkali dianggap sebagai “datangnya susu”, atau lactogenesis 2. Payudara dapat terasa hangat, kencang, tapi juga lembut. ASI yang berwarna putih kebiruan dengan tampilan susu skim (*true milk*) dapat keluar dari puting.

Ibu yang tidak menyusui

Payudara terasa membulat (nodular), namun berbeda dengan perabaan pada payudara perempuan yang tidak hamil. Bentuknya bilateral dan diffus. Kadar prolaktin segera menurun. Kolostrum tetap ada pada beberapa hari setelah persalinan. Palpasi pada hari ke-2 dan ke-3

menunjukkan jaringan yang lunak pada beberapa perempuan. Pada hari ke-3 atau ke-4, bendungan ASI dapat terjadi. Payudara membesar, kencang, lembut dan hangat jika disentuh. Pembesaran payudara ini umumnya karena munculnya pembuluh darah dan jaringan, bukan dari akumulasi ASI. Bendungan ini dapat teratasi dengan sendirinya, dan ketidaknyamanan menurun biasanya pada 24-36 jam sesudah terjadi.

6. Perubahan Psikologis

Sejak menjadi ibu dilihat sebagai “waktu yang menyenangkan” dan melahirkan dipandang sebagai sebuah hal yang harus segera dilalui dan segera kembali “bounce back” dalam beberapa hari, banyak perempuan yang mengalami kebingungan dan atau kehilangan dukungan dari sekelilingnya. Ibu membutuhkan kemampuan mengatasi keadaan untuk menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul dalam peran baru sebagai ibu. Penurunan secara tiba-tiba dari hormon estrogen, progesteron, endorpin, dan berbagai hormon lain dapat memicu respon seperti perubahan pada premenstrual.

Banyak perempuan yang merasa sangat kelelahan sesudah persalinan dan mungkin membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Persalinan dengan sectio cesarean kadang memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih.

Hipotiroid mungkin muncul pada awal setelah persalinan dan tanda-tanda defisiensi tiroid dapat menyerupai depresi.

Setelah perempuan dapat menjalani dengan baik kondisi berat pada kehamilan, tahapan persalinan, namun perhatian dari semua orang (keluarga, teman, dan pengasuh) seringkali tertuju pada bayi yang baru lahir. Perubahan fisik dan emosi yang sangat besar perlu untuk dikembalikan seperti keadaan sebelum hamil, namun ini seringkali jarang di hargai dan seringkali tidak ter evaluasi. Pemahaman yang baik tentang perubahan fisiologi pada masa nifas dapat membantu tenaga kesehatan untuk menyediakan dukungan yang tepat dan sangat dibutuhkan pada periode ini, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan lebih cepat.

C. Sectio Cesarea

1. Definisi Sectio Cesarea

Persalinan dengan sectio cesarea adalah persalinan melalui insisi transabdominal di rahim. Walaupun persalinan dengan sectio dapat direncanakan atau tidak direncanakan, namun kehilangan pengalaman persalinan melalui vagina, dapat mempengaruhi konsep diri seorang perempuan. Perhatian yang muncul lebih kepada kelahiran bayi, daripada prosedur operasinya.

Tujuan dilakukannya sectio cesarea adalah untuk menghadirkan kesehatan ibu dan bayi. Hal ini mungkin merupakan menjadi pilihan untuk persalinan yang memang terbukti untuk mencegah komplikasi ibu dan bayi. Sejak kemunculan metode bedah dan perawatan modern dan penggunaan antibiotik, maka terdapat penurunan kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Angka persalinan dengan metode sectio cesarea meningkat di banyak negara, terutama di negara

berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk janin dengan makrosomia, kehamilan dengan usia tua, ibu dengan BMI yang tinggi, diabetes dalam kehamilan, kehamilan ganda, dan distosia pada ibu primipara.

2. Manajemen Asuhan

Asuhan yang diberikan pada sectio cesarea meliputi persiapan prenatal, asuhan pre-operatif, asuhan intra operatif, asuhan segera setelah post-operatif dan asuhan masa nifas post-operatif.

Ibu yang baru melahirkan dengan sectio, membutuhkan perhatian yang segera, karena selain mereka sebagai pasien bedah, mereka juga sebagai ibu baru.

Asuhan yang segera diberikan pada ibu post sectio cesarea, mengikuti protokol yang berlaku termasuk derajat pemulihan dari efek anastesia, status pasca bedah dan status pasca persalinan, serta derajat rasa nyeri.

- a. Sesudah operasi, jumlah perdarahan harus dipantau ketat, dan memastikan kontraksi uterus dengan paslpasi uterus. Pasien juga di edukasi untuk batuk dan bernafas dalam.
- b. Pemberian analgesia secara intamuskular setiap 3 jam seperlunya untuk mengatasi ketidaknyamanan, disesuaikan dengan kebijakan dan protokol setiap tempat.
- c. Pemantauan tanda vital setelah dipindahkan ke ruang pemulihan setiap jam, kemudian dilanjutkan setiap 4 jam, yaitu termasuk tekanan darah, denyut nadi, suhu, kontraksi uterus, jumlah pengeluaran urin, dan jumlah perdarahan.

- d. Secara umum, kebutuhan cairan disesuaikan dengan perdarahan dan harus terbukti adekuat terdapat 3 liter cairan yang masuk selama 24 jam. Namun jika urin yang dihasilkan turun dibawah 30ml per jam, maka harus segera dievaluasi. Hal ini disebut sebagai oliguria, yang dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu perdarahan yang tidak diketahui atau efek diuretik dari infus oksitosin.
- e. Kateter kandung kemih umumnya dapat dilepas dalam 12 jam setelah persalinan atau untuk kenyamanan, dilepas pada pagi hari setelah operasi. Retensio urin sesudah operasi cesar secara relatif umumnya terjadi 15,6%, dengan variasi kejadian 5%-33,3%. Secara umum, etiologinya adalah jenis pembedahan, jenis anastesi yang dipakai saat operasi, dan penyakit penyerta dari pasien. Keadaan yang perlu diwaspadai dapat terjadi retensi urin yaitu jika penambahan berat badannya lebih besar dari normal, berat bayi lahir >4000 gram, persalinan yang sempit dilakukan induksi oksitosin, dan persepsi terhadap nyeri yang tinggi setelah dilepasnya kateter. Penggunaan USG secara rutin untuk menegakkan diagnosa retensio urine selama periode post operasi mungkin dapat bermanfaat (Cavkaytar dkk., 2015).
- f. Perempuan dengan persalinan cesar memiliki risiko mengalami emboli paru 2-20 kali lipat lebih besar daripada perempuan yang melahirkan melalui vagina. Angka kejadiannya berkisar antara 0,3-4,1% pada pembedahan ginekologi, dan 0,33-6,6% pada pembedahan abdomen. Hal ini masih merupakan tantangan untuk dapat dihadapi (Temgoua dkk., 2017). Faktor risikonya yaitu usia >35 tahun, IMT >30, paritas

- >3, operasi caesar darurat, histerektomi caesar, bersamaan dengan terjadinya infeksi, penyakit berat, preeklamsia, atau varises yang besar, imobilitas, dan trombosis vena atau trombofilia sebelumnya (Marik & Plante, 2008). Ambulasi dini dapat menurunkan risiko komplikasi sesudah sectio cesarea (Engel dkk., 2022)
- g. Beberapa teknik yang dapat diajarkan sebagai salah satu cara mengurangi nyeri tanpa obat-obatan setelah persalinan cesar yaitu (Lowdermilk dkk., 2019):
- 1) Tahan/bidai luka dengan bantal saat bergerak atau batuk
 - 2) Gunakan teknik relaksasi seperti musik, bernafas, atau lampu yang redup. Pada pasien muslim dapat digunakan murrotal al quran (Sulpat dkk., 2024)
 - 3) Berjalanlah sesering mungkin sesuai kemampuan
 - 4) Jangan memakan makanan yang mengandung gas, minuman berkarbonasi, susu utuh, atau es.
 - 5) Jangan menggunakan sedotan untuk minum
 - 6) Gunakan obat antifatulens jika di resepkan
 - 7) Berbaring pada sisi kiri untuk mengeluarkan gas
 - 8) Bergerak dengan kursi goyang

D. Murrotal Al Quran

1. Definisi

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT dan dijadikan sebagai kitab suci umat Islam yang ditujukan sebagai bimbingan spiritual manusia (Mahjoob dkk., 2016). Terapi komplementer mendengarkan Al Qur'an dilakukan dengan cara mendengarkan lantunan ayat suci Al Qur'an yang memberikan efek respon menenangkan baik secara psikologis dan fisiologis seseorang(Nurhasanah dkk., 2022).

Murrotal adalah lantunan bacaan dari Al Qur'an yang mengandung unsur suara manusia yang dapat menurunkan hormon stress, mengaktifkan endofin alami, meningkatkan relaksasi, mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, pernafasan, denyut nadi, denyut jantung, dan aktifitas gelombang otak (Wahyuningsih & Khayati, 2021).

2. Fungsi Neuroscience dalam Merespon Stress

Stress adalah respon tubuh pada stress mental seseorang di kehidupannya sehari-hari. Pemicu stress berasal dari dalam dan dari luar tubuh yang mempengaruhi sistem limbik, yang terdiri dari talamu, hipotalamus, amygdala, hippocampus, dan septum, serta fungsinya sebagai pusat regulasi dan adaptasi tubuh manusia. Hipotalamus memerankan peran utama pada hampir seluruh sistem limbik pada tubuh manusia.

Respon stress pada tubuh melewati beberapa jalan yang terhubung dengan hipotalamus, yang bisa disebut sebagai HPA pathway atau hipotalamus-pituitary-adrenal. Aktifitas HPA pathway melewati syaraf di inti paravestibular dalam hipotalamus, memproduksi CRH (corticotropin-releasing hormone).

CRH menyebabkan kelenjar pituitary anterior untuk melepaskan hormon adreno-corticotropin (ACTH) yang menstimulasi kelenjar korteks adrenal untuk melepaskan glukokortikoid atau kortisol. Kortisol dapat memengaruhi keseimbangan rasio dari sel Th1/Th2, kemudian di proses di korteks cerebral, dan di proses di hipotalamus melalui sistem limbik, kemudian di produksilah hormon CRH, yang merangsang kelenjar pituitari anterior melepaskan ACTH sebagai kelenjar korteks adrenal yang bertanggung jawab



Gambar 3.3 Pathway terapi murrotal terhadap nyeri pasca sectio sesarea

3. Murrotal Al Quran sebagai terapi

Penelitian sebelumnya telah mendapatkan bahwa keyakinan terhadap agama dan pendekatan spiritual dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik seseorang (Ab Rahman dkk., 2020). Mendengarkan ayat Al-Quran adalah strategi koping yang melengkapi perilaku muslim dalam menghadapi tantangan kesehatan mental. Selain itu, mendengarkan ayat-ayat Alquran telah terbukti efektif dalam mengurangi stres, nyeri dan kecemasan selama kehamilan, dan dalam mengelola depresi dan rasa sakit. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa dengan mendengarkan lantunan bacaan ayat-ayat Al Qur'an memiliki nilai terapi yang potensial dan dapat digunakan sebagai terapi non-farmakologis atau alternatif (Kannan dkk., 2022).

Komponen gelombang otak pada stimulan terapi musik dan stimulan murrotal al quran memiliki kesamaan, yaitu di dominasi oleh gelombang delta. Adanya gelombang ini menandakan bahwa kondisi seseorang sedang sangat rileks, sehingga stimulan Al Quran ini dapat memberikan ketenangan, dan kenyamanan bagi seseorang (Sulpat dkk., 2024). Gelombang delta normalnya muncul selama tidur dan kondisi yang rileks (Ahirwal & Londhe, 2012). Ketika seseorang mendengarkan terapi

murrotal, gelombang listrik pada otak pendengar dapat diperlambat dan dipercepat (Thalbah dkk., 2008).

Waktu pulih sadar pada pasien yang diperdengarkan Al-quran juga lebih cepat dibandingkan dengan terapi musik (Trisna & Musiana, 2022). Terapi al-quran yang dilakukan pada stress, kecemasan, depresi, kanker, nyeri (termasuk nyeri persalinan), penyakit jantung dan koma, menunjukkan bahwa intervensi al quran ini menunjukkan perbaikan dan peningkatan signifikan, bahkan pada kondisi yang melumpuhkan ini (Abdekhoda & Ranjbaran, 2022). Pembacaan Al quran yang dilantunkan penuh penghayatan dapat menimbulkan respon relaksasi.

4. Surat Al Mulk

Pemilihan surat Al- Mulk didasarkan pada kandungan maknanya yang berarti kasih sayang, yang terkandung di dalamnya keagungan Tuhan yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, bahkan ketika manusia sedang sakit. Selalu ada nikmat Tuhan yang harus disyukuri.

Membaca Surat Al- Mulk setiap hari membawa seseorang yang mendengarkannya lebih dekat kepada Tuhan, memberi ketenangan pikiran, dan menghapus semua kekhawatiran. Ketika seseorang merasa cemas dan stres, bacalah dan hati akan sembuh. Membaca Surah Al-Mulk akan banyak syafaat keberkahan yang dimiliki dalam hidup. Itu juga mengingatkan seseorang yang membacanya akan belas kasihan Tuhan.

5. Aplikasi Terapi Murrotal Al-Quran

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) terapi Murottal Al Qur'an berikut diadopsi dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anam, 2018; Handayani dkk., 2014; SAPUTRI, 2018; Sutrisno, 2018) adalah sebagai berikut:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERAPI MUROTAL AL QUR'AN	
Pengertian	Suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Qur'an selama waktu tertentu menggunakan <i>music player</i> .
Tujuan	Tujuan Umum Setelah mengikuti kegiatan mendengarkan murottal al Qur'an menggunakan <i>music player</i> diharapkan terjadi penurunan intensitas nyeri Tujuan Khusus Setelah mengikuti kegiatan mendengarkan murottal al Qur'an menggunakan <i>music player</i> klien mampu : Menekan respon nyeri yang dialami pasien setelah operasi seksio sesaria Nyeri yang dirasakan menurun
Indikasi	Pasien yang merasakan nyeri pasca seksio sesaria yang beragama Islam
Kontraindikasi	Pasien dengan gangguan pendengaran
Waktu	20 menit
Persiapan	Persiapan alat : 1. Pemutar musik / <i>MP3 player</i> 2. Suara Murottal Al Qur'an Surat Al-Mulk 3. Headphone

Persiapan pasien :	
1. Cek kebenaran identitas pasien 2. Cek kondisi fisik dan psikis pasien 3. Memberikan informed consent 4. Persiapan lingkungan : 5. Jaga privacy pasien 6. Menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan pasien	
Prosedur	Tahapan sebelum interaksi 1. Melakukan pengkajian dan mempelajari rekam medis pasien 2. Mencuci tangan dengan benar 3. Mempersiapkan peralatan 4. Memberikan salam teraupetik 5. Menanyakan kabar pasien dan kondisinya 6. Memastikan privasi klien 7. Memberikan penjelasan terkait tujuan & prosedur penelitian. 8. Mendengarkan Surat Al-Mulk yang akan dilakukan selama $\pm$ 20 menit.
Tahap kerja	
1. Menanyakan kepada pasien apakah ada pertanyaan sebelum tindakan dilakukan 2. Posisi pasien diatur dalam kondisi nyaman 3. <i>Headphone</i> dipasang pada pasien untuk membantu pasien berkonsentrasi dalam mendengarkan Murottal Al Qur'an dan supaya tidak mengganggu pasien lain 4. Hidupkan pemutar musik / <i>MP3 player</i> dan atur suara sesuai dengan kenyamanan pasien 5. Pasien diminta memejamkan mata	

dan berkonsentrasi pada lantunan Al Qur'an sedang dilantunan hingga selesai

6. Setelah selesai rapikan peralatan

Tahap terminasi

1. Respon pasien dan hasil kegiatan dicatat
 2. Berikan penguatan dan kalimat positif
 3. Menganjurkan pasien untuk melakukan terapi saat nyeri muncul
 4. Cuci tangan
-

Sumber: (Anam, 2018; Handayani dkk., 2014; SAPUTRI, 2018; Sutrisno, 2018), dengan modifikasi dari peneliti.

Bab 4

Karakteristik, Intensitas Nyeri dan Terapan Surat Al Mulk Pada Ibu Nifas SC Serta Terapi Murottal Al Qur'an Sebagai *Pain Relief* Dalam Asuhan Kebidanan Holistik

A. Karakteristik Ibu Post Partum

Karakteristik adalah tanda, ciri atau fitur yang bisa digunakan untuk identifikasi (Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), 2008). merupakan identitas yang melekat pada individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan dan lain lain. Karakteristik seseorang dapat memengaruhi kualitas hidup maupun kondisi sehat-sakit seseorang. Faktor karakteristik dapat memengaruhi rasa nyeri yang juga dirasakan oleh ibu nifas, seperti:

1. Usia

Usia seseorang akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut bereaksi dan berekspresi terhadap nyeri yang sedang dirasakan. Orang dewasa dan anak-anak akan berbeda dalam bereaksi terhadap nyeri.

Anak kecil kurang memahami terhadap nyeri yang sedang dirasakan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap respon dan mekanisme kopingnya. Pada orang dewasa, biasanya nyeri akan dilaporkan ketika sudah menjadi patologis dan mengganggu aktivitasnya. Selain menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, usia juga memengaruhi kondisi reproduksi seseorang. Usia 20-35 tahun termasuk usia reproduksi sehat yang aman untuk wanita hamil dan melahirkan (Esta, 2017). Namun penelitian juga menunjukkan bahwa rentang usia 20-35 tahun menjadi kelompok usia terbanyak melahirkan dengan cara operasi. Seyogyanya seorang wanita melahirkan dengan cara operasi haruslah atas indikasi medis seperti partus lama, disproporsi sepalo pelvic, panggul sempit, gawat janin, malpresentasi, rupture uteri mengancam, dan indikasi lainnya (Manuaba & Manuaba, 2007). Standar persalinan dengan SC sesuai rekomendasi World health organization (WHO) adalah sebesar 5-15%, namun survei menunjukkan persentase SC di Indonesia melebihi 17%. Meningkatnya angka kelahiran dengan SC di Indonesia terutama pada ibu-ibu di rentang usia 20-35 taun dikarenakan berkembangnya metode anestesi sehingga para ibu menjadikan persalinan SC sebagai alternatif cara melahirkan dibandingkan karena indikasi medis (Meivia Putri & Rafhani, 2023).

2. Gender

Gender kurang berpengaruh signifikan terhadap nyeri yang dialami oleh seorang individu. Laki-laki terlihat lebih tangguh dalam menerima dan menanggapi rangsangan nyeri yang diterimanya.

3. Paritas

Paritas merupakan jumlah kelahiran yang menghasilkan bayi dengan usia kehamilan di atas 26 minggu. Jumlah kelahiran lebih dari 2 mempunyai angka kematian yang lebih tinggi. Seorang wanita yang telah mengalami kehamilan sebanyak 2 kali atau lebih memiliki resiko lebih besar mengalami kontraksi yang lemah pada saat persalinan (Iradhatullah dkk., 2020).

4. Budaya

Budaya dan keyakinan yang dianut oleh individu akan mempengaruhi bagaimana berespon dan mengatasi nyeri yang sedang dirasakan. Individu mempelajari banyak hal dari apa yang diajarkan oleh kebudayaan mereka. Pentingnya mengkaji nilai-nilai budaya yang dianut oleh individu adalah berguna untuk menentukan intervensi yang akan diberikan.

5. Lingkungan

Lingkungan yang tidak kondusif akan mempengaruhi individu dalam berespon terhadap nyeri yang dihadapinya. Individu yang mendapatkan dukungan dari keluarga, teman dan lingkungan terdekat lainnya akan mampu mempersepsikan nyeri yang dirasakan lebih ringan jika dibandingkan individu yang merasakan nyeri tanpa mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat.

6. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang dalam penyelesaian proses pembelajaran secara formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan pengetahuan dan perilakunya juga semakin baik. Karena dengan pendidikan yang makin tinggi, maka informasi dan pengetahuan yang diperoleh juga makin banyak, sehingga perubahan perilaku kearah yang baik

diharapkan dapat terjadi. (Notoatmodjo, 2018) pendidikan ibu tetap tidak memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan persalinan yang menunjukkan pendidikan ibu bukan merupakan determinan penting terhadap pengambilan keputusan persalinan seksio sesarea. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Castiglioni, L., (2021) di Jerman terhadap 1020 kelahiran yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan formal ibu dengan persalinan sectio caesarea dimana ibu-ibu yang berpendidikan rendah cenderung memilih seksio sesarea sebagai jalan bersalin (Notoatmodjo, 2010).

7. Ansietas dan stress

Faktor ansietas akan memperberat rasa nyeri yang dirasakan individu.

8. Pengalaman nyeri masa lalu

Pengalaman nyeri yang pernah dialami oleh individu sebelumnya akan mempengaruhi respon nyeri yang dirasakan saat ini ketika ada stimulus. Individu yang memiliki pengalaman masa lalu nyeri yang buruk dan kronik, akan merasa takut dan cemas ketika dia merasakan stimulus nyeri yang baru. Hal ini akan menambah respon nyeri yang dirasakan semakin berat dan mengganggu.

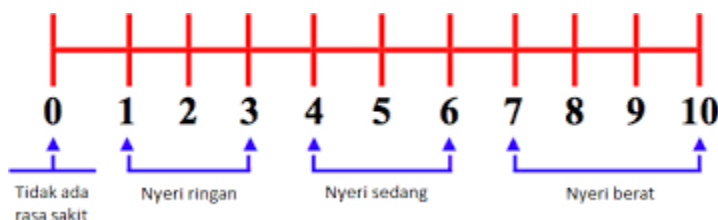
9. Ambang nyeri

Ambang batas nyeri diartikan sebagai intensitas stimulus minimum yang dapat menyebabkan nyeri. Suatu batas kemampuan seseorang untuk mau beradaptasi serta berespons terhadap nyeri. Ketika seseorang memiliki ambang nyeri rendah, akan lebih mudah merasakan nyeri ketika ada stimulus kecil saja (Sari & L.S, 2018).

B. Intensitas Nyeri pada Ibu Postpartum SC

1. *Numeric Rating Scale (NRS)*

Skala peringkat numerik atau NRS adalah alat skrining nyeri, yang biasa digunakan untuk menilai tingkat keparahan nyeri pada saat itu menggunakan skala 0-10, dengan nol berarti "tidak ada rasa sakit" dan 10 berarti "rasa sakit terburuk yang bisa dibayangkan. Pertanyaan skala peringkat numerik meminta peserta survei untuk mengukur preferensi, perasaan, persepsi, dan minat pada skala numerik yang disediakan. Skala tersebut merupakan skala bilangan urut dengan rentang yang ditentukan oleh peneliti untuk mewakili titik ekstrim dari nilai yang diukur.



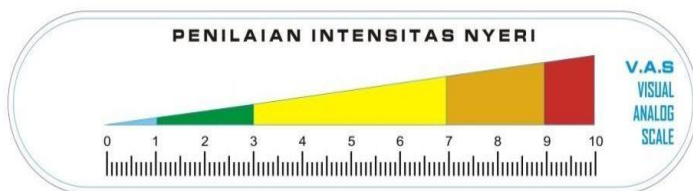
Gambar 4.1 *Numeric Rating Scale*

2. *Visual Analog Scale (VAS)*

Skala Analog Visual (VAS) adalah salah satu skala peringkat nyeri yang digunakan pertama kali pada tahun 1921 oleh Hayes dan Patterson. Ini sering digunakan dalam penelitian epidemiologi dan klinis untuk mengukur intensitas atau frekuensi berbagai gejala. Misalnya, jumlah rasa sakit yang dirasakan pasien berkisar dari tidak merasakan sakit sampai merasakan sakit ekstrim. Dari sudut pandang pasien, spektrum ini muncul terus menerus ± rasa sakit mereka tidak mengambil lompatan diskrit, seperti yang disarankan oleh kategorisasi tidak ada, ringan, sedang dan berat. Untuk menangkap gagasan

tentang kontinum yang mendasari inilah VAS dirancang (Andarmoyo, 2013).

VAS merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linier ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeter. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Skala dapat dibuat vertical atau horizontal. Digunakan pada pasien >8 tahun dan dewasa. Manfaat utama VAS adalah penggunaannya mudah dan sederhana. VAS adalah metode pengukuran intensitas nyeri paling sensitive, murah dan mudah dibuat (Chiarotto dkk., 2019)



Gambar 4.2 Visual Analog Scale (VAS)

Cara penilaiannya adalah dengan mengukur jarak dari batas kiri (angka 0) sampai pada tanda titik yang diberi oleh pasien dan itulah skor yang menunjukkan level intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian skor tersebut dicatat dan didokumentasikan (Yudiyanta, 2015). Cara membaca hasil pengukuran nyeri VAS yaitu dengan menggunakan sebuah tabel garis 10 cm dengan

pembacaan skala 0–100 mm dengan rentangan makna sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Ukur Nyeri Skala VAS

Skala VAS	Keterangan
0	Tidak nyeri
1	Hampir tidak menyadari rasa sakit
2	Menyadari nyeri, tetapi tidak mengganggu aktivitas
3	Nyeri terkadang mengganggu
4	Nyeri mengalihkan perhatian, dapat melakukan aktivitas seperti biasa
5	Nyeri mengganggu beberapa aktivitas
6	Nyeri sulit diabaikan, menghindari aktivitas biasa
7	Fokus perhatian, mencegah melakukan aktivitas sehari-hari
8	Sulit untuk melakukan apapun
9	Tidak tahan sakit, sulit berbuat apa-apa
10	Seburuk apa pun itu, tidak ada hal lain yang penting

(Sari & L.S, 2018)

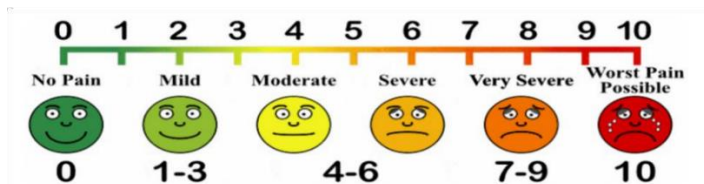
Keuntungan yang paling jelas dari VAS adalah bahwa mereka menawarkan tingkat resolusi yang sangat tinggi dan karenanya pilihan nuansa penilaian yang sangat baik. Responden tidak terikat dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya yang berpotensi terlalu ketat dan, sebagai hasilnya, dapat mengekspresikan diri mereka dengan lebih bebas. Itu juga bisa dibilang alasan mengapa individu yang sikapnya berada di antara dua kategori lebih memilih jenis skala ini. Pengukuran berulang dapat menunjukkan bahkan perubahan menit

yang tetap dianggap oleh pasien sudah sangat relevan dalam beberapa kasus.

Tingkat detail yang tinggi dalam VAS, di atas segalanya, merupakan keuntungan dalam hal item dengan varian rendah dan memungkinkan tes berbasis peringkat untuk digunakan secara efektif. Dalam kasus item dengan varian rendah, banyak kasus jatuh ke dalam satu kategori— dengan demikian membuatnya tidak dapat dibedakan satu sama lain—dan diberi posisi yang sama dalam peringkat. Dengan VAS, bahkan kasus-kasus yang sangat mirip pun dapat dibedakan satu sama lain . Variasi signifikansi interval identik pada VAS sebagaimana ditafsirkan oleh pengguna yang berbeda dengan demikian lebih kecil dibandingkan dengan skala kategori di mana nilai kategori individu lebih berfluktuasi di antara pengguna yang berbeda.

3. Skala Nyeri Wajah (*Wong-Baker FACES Pain Rating Scale*)

Bentuk pengukuran skala nyeri dengan cara melihat ekspresi wajah yang ditampilkan oleh klien. Alat ukur terdiri gambar kartun ekspresi wajah mulai dari ekspresi senyum berlanjut dengan wajah kurang bahagia, sedih dan wajah yang menunjukkan ketakutan (Andarmoyo, 2013).



Gambar 4.3 Skala nyeri wajah

Penatalaksanaan Nyeri

1. Farmakologi

- a. *Analgesik perifer (non-opioid)* : tidak bersifat adiktif dan kurang kuat dibandingkan dengan analgesik narkotik. Digunakan untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang dan dapat dibeli bebas. Efektif untuk nyeri kepala, dismenore, nyeri otot dan nyeri pada inflamasi.
- b. Analgesik narkotik (opioid) : Untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat dan bekerja pada sistem saraf pusat. Digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat misalnya pada pasien kanker, nyeri organ dan tulang. Memiliki efek samping yaitu depresi pernapasan, hipotensi ortostatik (penurunan tekanan darah ketika bangun dari posisi duduk atau berbaring), takikardi, mengantuk, konstipasi, dan retensi urin. Contoh Jenis obat-obat yang termasuk opioid analgesik adalah seperti morfin, meperidin (petidin), fentanil, buprenorfin, dezodin, nalbupin, nalorfin, dan pentasozin. Beragam jenis obat opioid analgesik memiliki rata – rata waktu paruh sepanjang 4 jam (Chou dkk., 2016).

2. Non Farmakologi

- a. Teknik relaksasi nafas dalam

Terapi penggunaan otot pernafasan membuat perubahan arus listrik di otot tubuh, kelancaran sirkulasi darah dan kulit bagus. Relaksasi digunakan dengan melihat dampak positifnya yaitu menurunkan denyut jantung, respirasi dan ketegangan otot sehingga nyeri bisa menurun.

Tindakan relaksasi bisa dilakukan dengan cara relaksasi nafas dalam.

b. Guided imagery

Teknik untuk menurunkan nyeri yang dialami klien dengan cara mengajak dan membimbing klien untuk berkonsentrasi penuh dengan visualisasi tempat-tempat yang indah, menyejukkan dengan situasi yang damai dan tenang.

c. Distraksi

Ditraksi dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan fokus perhatian klien pada hal lain yang menarik dan menyenangkan, sehingga dapat menurunkan respon klien terhadap nyeri yang dialaminya. Distraksi bisa dilakukan dengan cara melihat video atau hiburan televisi, mendengarkan musik, mendengarkan Al Qur'an dan masih banyak teknik lainnya (Benzon dkk., 2022).

C. Terapan Al Qur'an Surat Al Mulk Pada Ibu Nifas dengan SC

Terapi komplementer mendengarkan Al Qur'an dilakukan dengan cara mendengarkan lantunan ayat suci Al Qur'an yang memberikan efek respon menenangkan baik secara psikologis dan fisiologis seseorang (Nurhasanah dkk., 2022). Al-Qur'an dapat menjadi penyembuh sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' Ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: "Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang salim selain kerugian".

Manfaat

Mendengarkan ayat-ayat Al Qur'an adalah strategi koping pelengkap untuk perilaku Muslim dan tantangan kesehatan mental. Semakin banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui efek dan manfaat mendengarkan lantunan murotal Al Qur'an terhadap kesehatan mental dan fisik manusia. Beberapa ayat Alquran diyakini memiliki dampak penyembuhan dan digunakan dalam terapi alternatif yang dikenal dengan syifa'. Selain itu, mendengarkan ayat-ayat Alquran telah terbukti efektif dalam mengurangi stres, nyeri dan kecemasan selama kehamilan, dan dalam mengelola depresi dan rasa sakit. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa dengan mendengarkan lantunan bacaan ayat-ayat Al Qur'an memiliki nilai terapi yang potensial dan dapat digunakan sebagai terapi non-farmakologis atau alternatif (Kannan dkk., 2022).

Mendengarkan murotal Al Qur'an bermanfaat dalam merangsang serabut syaraf dan gelombang alfa yang menyebabkan efek relaksasi, nyaman damai dan tentram. Selain itu terapi murottal Al Qur'an bermanfaat dalam memberikan ketenangan jiwa, penghilang kecemasan, menurunkan perilaku kekerasan, dan meningkatkan efektivitas perkembangan untuk anak autis (Millizia dkk., 2021)

D. Integrasi Spiritual Islam Sebagai Bagian dari Kesehatan Holistik

Kata holistik berasal dari bahasa Yunani "holos" (wholeness, keutuhan-Ind), holism yang bermakna berkaitan dengan keseluruhan unit dan bukan sebagai penjumlahan dari bagian-bagian individualnya. Perawatan holistik adalah

tentang merawat manusia/individu secara keseluruhan. "Sebab suatu bagian tidak akan pernah baik jika keseluruhannya tidak baik." Socrates (470–399 SM) .

Asuhan kesehatan holistik adalah pelayanan pasien yang menyeluruh atau total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang, responsnya terhadap penyakit, dan pengaruh penyakit terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan perawatan diri. Kesehatan holistik terdiri dari beberapa dimensi, yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual (Ventegodt dkk., 2016)

Bagaimana konsep spiritual dan spiritualitas dikembangkan?

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia secara luas menggunakan istilah spiritualitas untuk merujuk pada warisan mistik asli dari aliran kepercayaan atau kebatinan. Penggunaan istilah-istilah tersebut akhir-akhir ini menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat dari agama-agama dunia di Indonesia, terutama Islam, dalam menyerap dan memperolehnya sebagai ekspresi batin keagamaan. Tren ini sangat berbeda dengan yang terjadi di Barat, dimana tumbuhnya spiritualitas berkorelasi dengan menurunnya afiliasi dan partisipasi Barat dalam agama.

Pengertian Spiritual

1. *Spirit* (bahasa Inggris) = kekuatan dalam diri seseorang yang diyakini memberikan kehidupan, energi, dan kekuatan pada tubuh. Kekuatan pendorong yang memberi makna, stabilitas, dan tujuan hidup melalui keterhubungan dengan dimensi yang melampaui diri (Rovers & Kocum, 2010).

2. Pertanyaan-pertanyaan utama tentang makna hidup dalam kaitannya dengan yang transenden, yang mungkin muncul atau tidak muncul dalam tradisi keagamaan formal (Koenig, MD, 2008).
3. Spiritualitas dalam konsep Islam diartikan sebagai adanya hubungan dengan Allah yang memengaruhi harga diri individu, makna, dan keterhubungan dengan orang lain.

Fisher, membagi spiritualitas menjadi empat dimensi, yaitu *personal*, *communal*, *environmental* dan *transcendental*. Dimensi *personal* adalah kondisi dimana seseorang berhubungan secara internal dengan dirinya sendiri, sedangkan *communal* adalah dimensi individu secara interpersonal/antar pribadi. *Environmental* adalah hubungan seseorang dengan alam dan lingkungan sekitar, adapun *transcendental* adalah merupakan dimensi yang melihat hubungan individu dengan suatu kekuatan yang lebih besar/di atas manusia.

Kesehatan spiritual didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang mampu menghadapi masalah kehidupan sehari-hari dengan cara yang mengarah pada realisasi potensi, makna dan tujuan hidup serta kepuasan penuh dari dalam diri seseorang.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa asuhan spiritual meningkatkan hasil kesehatan yang lebih baik termasuk pencegahan dan pemulihan penyakit, perasaan sejahtera yang menyeluruh dan peningkatan kemampuan untuk mengatasi penyakit serta menyesuaikan diri dengan peristiwa kehidupan yang berhubungan dengan stres. Selain itu mereka juga terlibat dalam penurunan angka bunuh diri, penyalahgunaan narkoba, perceraian dan depresi pada beberapa populasi (Drury & Hunter, 2016). Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara spiritualitas

dengan resiliensi berikut dampaknya terhadap penyembuhan, kesejahteraan emosional, mental, serta penanggulangan dan ketahanan (Sharma, 2017).

Penelitian lain menemukan bahwa spiritualitas dan religiusitas yang tinggi dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik termasuk berkurangnya depresi, kecemasan, dan stres (Koenig, 2012). Pada pasien hemodialisis, penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual dan religiusitas yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan kemungkinan depresi, kecemasan, dan stres (Martinez dkk., 2011).

Hubungan antara jasmani, pikiran dan rohani (spiritual) dapat dijelaskan sebagai berikut : kondisi spiritual yang sejahtera dapat meningkatkan ketahanan pikiran seseorang terhadap stress dan menurunkan emosi-emosi negatif sehingga menghasilkan relaksasi.

Hubungan Positif Antara Kesehatan Spiritual dan Mental Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an

"Orang-orang yang beriman dan hatinya tenteram dengan mengingat Allah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram" (Qur'an 13:28)

"Dan sesungguhnya Kami akan menguji kamu dengan rasa takut, lapar, dan hilangnya harta, nyawa, dan buah-buahan, tetapi kami akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika mereka ditimpa musibah, katakanlah, "Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya"" (Qur'an 2: 155-156)

E. Murottal Al Qur'an sebagai Pain Relief

Intervensi kognitif spiritual yaitu dilakukan dengan cara mengubah pikiran negatif seseorang dengan melibatkan sisi spiritual klien. Efek fisiologis Al-Qur'an dicapai melalui mekanisme melalui pemaknaan Al-Qur'an bagi yang memahami artinya, dan yang tidak memahami terjemahannya pun masih bisa meresapi maknanya. Selain itu, melalui suara kata-kata Al-Qur'an berbahasa Arab, bahkan pada mereka yang tidak mengerti artinya, yang dapat bertindak sebagai terapi suara untuk memberikan ketenangan (Frih dkk., 2017).

Pengobatan al-Qur'an memiliki efek suportif dalam pengobatan suatu penyakit. Penelitian telah menguraikan aturan pengobatan melalui ayat-ayat Al-Qur'an untuk gangguan fisik. Menurut tinjauan sistematis, kesamaan antara apa yang dikemukakan dalam beberapa penelitian dapat ditelusuri kembali ke konsep dan implementasi penggunaan al-Qur'an sebagai obat, juga dikenal sebagai shifaa, terutama untuk gangguan fisik. Studi ini mendukung premis bahwa terapi Al-Qur'an menjanjikan untuk menghilangkan rasa sakit fisik di antara pasien pasca operasi (Millizia dkk., 2021).

Pemilihan Al Quran sebagai modalitas pengobatan perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain jenis murottal dan surat Al Quran. Pemilihan jenis murottal ditentukan berdasarkan irama dan tempo. Ritme reguler dengan kecepatan rendah dipilih berdasarkan penelitian dengan modalitas musik. Studi tersebut menyatakan bahwa ritme dan tempo musik mempengaruhi perubahan gelombang alfa dan beta berdasarkan pengamatan pada elektroensefalogram. Surat Quran ditentukan oleh makna tersirat. Pemilihan surat Al Mulk didasarkan pada kandungan

maknanya yang berarti kasih sayang. Di dalamnya terkandung keagungan Tuhan yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, bahkan ketika manusia sedang sakit. Selalu ada nikmat Tuhan yang harus disyukuri.

Gelombang suara dari pembacaan ayat Al Quran atau murattal Al Quran akan masuk melalui telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, mengguncang cairan di telinga dalam serta menggetarkan sel sel berambut di dalam Koklea. Selanjutnya melalui saraf Koklearis menuju ke otak. Tiga jaras Retikuler yang berperan dalam gelombang suara yaitu jaras retikuler-talamus, hipotalamus. Gelombang suara diterima langsung oleh Talamus, yaitu suatu bagian otak yang mengatur emosi, sensasi, dan perasaan, tanpa terlebih dahulu dicerna oleh bagian otak yang berpikir mengenai baik buruk maupun intelegensia. Kemudian melalui Hipotalamus memengaruhi struktur basal forebrain termasuk sistem limbik. Hipotalamus merupakan pusat saraf otonom yang mengatur fungsi pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, pergerakan otot usus, fungsi endokrin, memori, dan lain-lain. Selanjutnya, melalui akson neuron berdifusi mempersarafi neo-korteks. Efeknya adalah meningkatkan relaksasi, ketenangan dan kenyamanan, membantu mengatasi insomnia, meningkatkan imunitas, dan menstabilkan pernapasan (Vava Rilla dkk., 2014).

Terapi murottal dengan memutarakan bacaan surat Al Mulk sangat manjur karena bisa memunculkan rasa damai, perasaan tenang dan juga rileks sehingga sakit dapat diturunkan dengan pemutaran musik yang bisa menetralkan tanda-tanda vital pasien dan membuat klien nyaman dengan meningkatkan rasa damai dan tenang melalui indra pendengaran.

Jika kita menganalisis suara Al-Qur'an, merupakan frekuensi audio atau gelombang yang dikirim kepada kita melalui udara, gelombang suara yang ditransmisikan ketelinga kemudian berubah menjadi isyarat-isyarat elektronik, kemudian ia berjalan melalui saraf pendengaran dalam otak dan sel-sel tubuh memberi respon kepadanya, dari sini gelombang suara beralih ke berbagai wilayah otak terutama bagian depan, dengan demikian getaran suara dapat mempengaruhi getaran sel tubuh (al-Kaheel, 2012).

Harmonisasi gelombang terapi murottal Al-Qur'an dapat menurunkan hormon stres (kortisol), dan meningkatkan hormone endorphen yang menimbulkan perasaan rileks serta menyebabkan aktivasi system saraf parasimpatis ditandai sirkulasi tubuh, detak jantung, sirkulasi nafas, menjadi tenang sehingga mampu menurunkan tingkat emosional seseorang (Handayani dkk., 2014).

Bab 5

Penutup

Bidan berperan penting dalam penanganan nyeri pasca seksio sesarea sedini mungkin dengan cara memberikan pelayanan kesehatan holistik secara langsung kepada klien guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, khususnya kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan fakta dari praktek dan evaluasi dalam buku pelayanan kebidanan, fokus utama asuhan kebidanan masih sebatas pemenuhan kebutuhan fisik dan mental, sangat sedikit sentuhan asuhan kebidanan.

Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang pencapaian kesehatan holistik yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial telah lama ditetapkan sebagai tujuan pelayanan kesehatan Indonesia. Filosofi Pancasila, khususnya bangsa Indonesia dengan sila pertama, bersifat religius dan selalu menyertai hadirat Sang Pencipta, baik dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam keadaan sakit. Hal pertama yang dilakukan orang Indonesia ketika sakit adalah berdoa dan melakukan ritual keagamaan. Keberadaan bidan yang tidak dapat menggantikan bidan dalam waktu yang lama juga disebabkan oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan spiritual ibu selama hamil dan melahirkan. masa persalinan Mereka membutuhkan bimbingan doa untuk

menenangkan pikiran mereka dan memperkuat kondisi mental mereka selama masa stres dan kesusahan. Kebutuhan spiritual ini tidak dapat dipenuhi oleh tenaga medis umum di Indonesia (Unisa Bandung., 2021).

Penatalaksanaan nyeri pasca seksio sesarea secara holistik yang dilakukan oleh dokter dan bidan salah satunya dengan terapi murattal Al-Mulk namun ada berbagai upaya lain dalam penatalaksanaan holistik yaitu berkolaborasi dengan terapis yang bisa mengatasi nyeri pasca seksio sesaria. Beberapa alternatif terapi yang bisa menstabilkan nyeri antara lain; akupuntur, akupresur, biofeedback, meditasi, yoga, stress management, hypnobirthing dan mendengarkan murotal Al-Quran.

Dalam sebuah hadist dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap penyakit bisa diatasi asalkan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Bunyi sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

سَقَمًا يُغَادِرُ لَا شِفَاءَ أَنْتَ إِلَّا شَافِي لَا الشَّافِيَ أَنْتَ اشْفِ الْبَاسَ أَذْهَبِ النَّاسَ رَبِّ لِلْهُمِّ

Artinya: "Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkan lah penyakit ini, sembuhkan lah, hanya Engkau lah yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit."

Do'a meminta kesembuhan tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi:

الرَّحِيمِينَ أَرْحَمُ وَأَنْتَ الضُّرُّ مَسْنِي أَيْ رَبِّهٖ

Artinya: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang."(Al-Anbiya:83).

Hadirnya buku ini, kami menekankan bahwa:

1. Tatalaksana nyeri pada ibu post sectio cesarea sangat dibutuhkan, dan tidak bertumpu hanya pada metode menggunakan obat-obatan, namun juga bisa dengan komplementer seperti murrotal al quran terutama pada wilayah yang mayoritas penganut agama Islam
2. Petugas kesehatan sebagai pemberi pelayanan sebaiknya dapat menganalisa kebutuhan klien, dan dapat memberikan pelayanan secara holistik
3. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga kesehatan tentang terapi non farmakologi sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan yang holistik.

Terimakasih kamu hanturkan kepada para pembaca, semoga informasi yang kami paparkan dapat bermanfaat dan berdampak pada penurunan angka morbiditas dan mortalitas ibu post SC.

Glosarium

Glossarium

A

- Asuhan : Pelayanan
Al Qur'an : nama kitab agama Islam
Arab : Nama Bangsa di Timur Tengah
After pain : Sakit Sesudah Melahirkan

B

- Bayyati : Jenis Irama Maqammat

C

- CRH : *Corticotropin-Releasing Hormone*

D

- Delta : Gelombang otak yang terjadi saat tidur

E

- Endorphine : Hormon yang terlibat dalam penurunan rasa sakit

F

- Farmakologi : Ilmu tentang obat-obatan dan cara kerjanya

Profil Penulis



Maya Sukmayati, S.ST.,M.KM.

Lahir di Bandung, 02 Desember 1974. Merupakan dosen pada Pendidikan Bidan Profesi Universitas 'Aisyiyah Bandung. Penulis menamatkan pendidikan D4 Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2009. Penulis menempuh Pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan bidang peminatan Kesehatan Reproduksi Di Universitas Padjadjaran tahun 2015. Sebagai dosen pada salah satu amal usaha milik organisasi 'Aisyiyah, aktifitas sehari-hari penulis terkait pekerjaan saat ini melaksanakan catur dharma perguruan tinggi berupa pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan aktif di kemuhammadiyah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maya.sukmayati@unisa-bandung.ac.id

Profil Penulis



Giari Rahmilasari, S.ST., M.Keb., Bdn.

Bandung, West Java, Indonesia

+62877-22418147

gairirahmilasari@unisa-bandung.ac.id

Moto:

I love learning and I like to share knowledge

Experience

2004–2008 : Midwifery • staff • Rumah Bersalin Cuma-Cuma
2008–2010 : Lecturer • Akademi Kebidanan Tri Dharma Husada
2011–present : Lecturer • staff • Universitas Aisyiyah Bandung
Education : Master of Midwifery in Padjadjaran University,
Bandung, West Java, Indonesia

Research

- Self Regulation and Anxiety On Home Visit and Clinical Visit (A Cohort Study In Postpartum Mother
- Keluarga dan Nilai Budaya Masyarakat Sunda Pada Perawatan Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir
- Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Pendampingan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Monitoring Masa Nifas)
- Kecerdasan Adversitas dan Kecemasan pada Ibu Nifas dalam Menghadapi Era Baru Endemi COVID-19
- Analisis Kebutuhan Informasi pada Promosi Kesehatan Tema Menyusui
- Early mobilization and post-cesarean delivery pain management
- Etc.

Leadership

- Head of Midwifery Study Programme (Diploma 3) in Tri Dharma Husada (2008-2010)
- Head of Midwifery Study Programme (Diploma 3) in STIKes Aisyiyah Bandung (2014-2017)

SINOPSIS

Buku **“Murottal AL Qur'an Surat Al Mulk: Terapan Dalam Asuhan Kebidanan Sebagai Pengurang Rasa Nyeri Pasca Operasi SC”** ini menghadirkan konsep tilawah dan aplikasi murottal sebagai pendekatan inovatif dalam mengurangi rasa nyeri pada ibu nifas pasca operasi seksio sesaria. Melalui pembahasan mendalam, dijelaskan bagaimana murottal Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Mulk, dapat berfungsi sebagai metode relaksasi yang efektif dalam meredakan nyeri. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim, buku ini mengajak pembaca untuk memanfaatkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang kesehatan. Ditulis berdasarkan penelitian dan praktik, buku ini memberikan panduan penggunaan murottal sebagai salah satu bentuk asuhan komplementer yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan kebidanan.

Buku "Murottal AL Qur'an Surat Al Mulk: Terapan Dalam Asuhan Kebidanan Sebagai Pengurang Rasa Nyeri Pasca Operasi SC" ini menghadirkan konsep tilawah dan aplikasi murottal sebagai pendekatan inovatif dalam mengurangi rasa nyeri pada ibu nifas pasca operasi seksio sesaria. Melalui pembahasan mendalam, dijelaskan bagaimana murottal Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Mulk, dapat berfungsi sebagai metode relaksasi yang efektif dalam meredakan nyeri. Sebagai masyarakat mayoritas Muslim, buku ini mengajak pembaca untuk memanfaatkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang kesehatan. Ditulis berdasarkan penelitian dan praktik, buku ini memberikan panduan penggunaan murottal sebagai salah satu bentuk asuhan komplementer yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan kebidanan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-29-0



9

786347

139290